



METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LA POBREZA EN LA PRIMERA INFANCIA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS Y CAPACIDADES

Alumna: Ana Elisa Kuhn

Profesor Guía: Javier Bronfman

Profesores correctores: Daniela Aldoney
Andrés Hernando

**MEMORIA PARA OPTAR AL MAGÍSTER EN ECONOMÍA
Y POLÍTICAS PÚBLICAS**

SEPTIEMBRE, 2019

RESUMEN

La pobreza infantil es un fenómeno que siempre ha estado presente en la sociedad, pero a diferencia de los adultos, un niño al verse expuesto a pobreza no necesariamente es consciente de que se encuentra privado y por tanto crece ante ciertas situaciones que a sus ojos son “normales” sin saber que lo marcarán a lo largo de su vida y que existen realidades mejores.

El objetivo de este estudio es proponer una metodología que incluya dimensiones sensibles a los niños en la primera infancia desde un enfoque de derechos y capacidades. El enfoque de derechos asegura mínimos sociales en los que un niño debería desarrollarse, mientras que las capacidades son aquellas que le permitirán desarrollar funcionamientos para desarrollar el plan de vida que le gustaría vivir.

Para establecer la metodología primero se explora cuáles son las capacidades y cómo estas guardan relación con el niño, una vez que se conoce esto, se busca un método que permita operacionalizarlas y así medir estados de privación.

La metodología que se propone considera un listado de capacidades que sirven de dimensiones para la medición multidimensional de la primera infancia, junto a esto se establece cuál es la relación entre un derecho y una capacidad y se proponen indicadores que sirven para la medición.

Finalmente, se muestra una aplicación al caso chileno, utilizando datos de la Encuesta Longitudinal de la Primera Infancia (ELPI). Entre los hallazgos se encuentra que existe una mayor proporción de niños que se encuentran privados con relación a las niñas.

AGRADECIMIENTOS

A mi profesor guía Javier Bronfman, por acompañarme y apoyarme constantemente durante este proceso, por confiar en mi trabajo, por su paciencia, predisposición y sabiduría; por todos los aprendizajes que me entregó, lo que hizo posible lograr la conclusión de esta tesis.

Agradezco también a mis profesores correctores: Daniela Aldoney y Andrés Hernando, por sus valiosas observaciones y aportes en mi trabajo, brindando una mirada distinta, lo que permitió dar al estudio un enfoque multidisciplinario.

A mi querida madre, que me acompañó durante todo este proceso, por su apoyo incondicional, y brindarme el aliento y la contención en los momentos en que más lo necesitaba.

Y finalmente a mi abuela, quien, a pesar de no acompañarme en vida, estoy segura de que se alegraría por mis logros.

ABREVIACIONES

ADD	Trastorno de déficit atencional
ADHD	Trastorno de déficit de atención e hiperactividad
CASEN	Encuesta de Caracterización Socioeconómica
CBCL	Child Behavior Checklist
CDN	Convención de Derechos del Niño
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CHIP	The Childhood Poverty Research and Policy Centre
CNI	Consejo Nacional de la Infancia
CONEVAL	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (México)
CPR	Constitución Política de la República de Chile
CRC	Comité de Derechos del Niño (por sus siglas en inglés Child Rights Committee)
ELPI	Encuesta Longitudinal de la Primera Infancia
IMC	Índice de Masa Corporal
NNA	Niños, Niñas y Adolescentes
OMS	Organización Mundial de la Salud
OPS	Organización Panamericana de la Salud
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
SIENA	Sistema Estadístico sobre la Niñez y Adolescencia
UNICEF	Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

ÍNDICE

RESUMEN	2
ABREVIACIONES	4
1. INTRODUCCIÓN.....	7
2. ASPECTOS CONCEPTUALES	9
2.1. Primera infancia y su importancia.....	9
2.2. Pobreza.....	11
2.3. Capacidades y funcionamientos.....	12
3. MEDICIONES DE POBREZA INFANTIL.....	15
4. METODOLOGÍA.....	19
4.1. Elección de dimensiones: Selección de capacidades	19
4.2. Elección de indicadores por dimensión	24
4.3 Unidad de análisis	30
4.4 Criterios de identificación	30
4.5 Orden de agregación	32
5. CASO CHILENO	33
5.1 Mediciones de pobreza en Chile	33
5.2. Aplicación para Chile	34
5.3. Construcción de indicadores	36
5.4. Análisis y resultados	40
6. CONCLUSIONES.....	45
7. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS.....	47
8. ANEXOS	52
Anexo A: Metodología CONEVAL	52
Anexo B: Decálogo de capacidades centrales para el funcionamiento humano de Martha Nussbaum.....	54
Anexo C: Objetivos epistemológicos, metodologías y rol de los funcionamientos y capacidades.....	56
Anexo D: Derechos e institucionalidad en relación a la infancia en Chile	57
Anexo E: Definición de indicadores y umbrales de privación severa y moderada entre los niños	60
Anexo F: Umbrales de privación por variables (no censurado).....	62
Anexo G: Clasificaciones de enfermedades de acuerdo a la clasificación internacional de la Organización Panamericana de la Salud	74

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Listado de capacidades, sus definiciones y relación con los Derechos de los Niños	23
Tabla 2: Dimensiones e indicadores por dimensión.....	25
Tabla 3: Unidad de análisis de acuerdo a cada dimensión	30
Tabla 4: Resultados bajo la metodología de Alkire y Foster (2011), para menores de 15 años encontrados por Denis et al. (2010)	34
Tabla 5: Edad de los niños que componen la muestra	35
Tabla 6: Dimensiones, indicadores y pesos	36
Tabla 7: Estimaciones de pobreza multidimensional en la primera infancia para diferentes umbrales de privación (k).....	41
Tabla 8: Índice de recuento por sexo	42
Tabla 9: Índice de recuento bruto (no censurado)	42
Tabla 10: Índice de recuento bruto (no censurada) para la dimensión de refugio y medio ambiente	43
Tabla 11: Índice de recuento bruto (no censurada) para la dimensión de amor y cuidado	44
Tabla 12: Índice de recuento bruto (no censurada) para la vida y salud	44

1. INTRODUCCIÓN

La pobreza es el resultado de procesos sociales y económicos en que las personas se encuentran privadas de activos y oportunidades a los que tienen derecho todos los seres humanos. La pobreza en la infancia adquiere un carácter especial debido a que no puede ser vista de la misma manera que la pobreza de adultos, es por eso que se requiere de metodologías que sean adecuadas para medir privaciones en relación a esta etapa de la vida, así como también deben ser los niños la unidad de análisis de la medición y no el hogar.

En la actualidad existen veintiséis experiencias de medición de pobreza en la infancia, de ellas el enfoque más utilizado para la medición es en enfoque de derechos, este considera que un niño al experimentar determinadas privaciones tendrá alguno de sus derechos privados. Una debilidad de los estudios que utilizan este enfoque es que consideran sólo algunos derechos y no la totalidad, por lo que podrían considerarse como enfoques incompletos.

Este estudio propone una metodología para la medición de la pobreza en la primera infancia desde el enfoque de derechos y capacidades. Para establecerlo se identifican cuáles son las capacidades relevantes que deben ser consideradas en base a lo planteado por los mismos niños en el “Congreso Mundial de Trabajo Infantil” del año 2004, a ellos se les preguntó qué capacidades consideraban importantes para sí mismos dando como resultado un listado de 14 capacidades; el involucrarlos en este proceso permite que dejen de ser objetos de Derecho a sean sujetos de Derecho, dado que sus opiniones son tomadas en cuenta en procesos que los involucran. En línea con Sen (2004), no es posible establecer un listado de capacidades sin que pasen por un proceso de deliberación pública en la que los principales involucrados no participen.

La metodología utiliza como línea base este listado de capacidades, las cuales cumplen con una serie de requisitos conceptuales que permiten establecerlas como dimensiones para la medición de pobreza infantil, además se relaciona de manera directa con los derechos contenidos en la Convención de Derechos del Niño (CDN).

Para establecer los indicadores que componen cada una de estas dimensiones se revisan los estudios de Pobreza Multidimensional enfocados en la Infancia y se analiza sus indicadores. Este proceso da como resultado la metodología de pobreza multidimensional para la primera infancia, la cual propone dimensiones e indicadores para su medición y establece la relación que existe entre capacidades y derechos.

El documento se estructura de la siguiente manera: el segundo capítulo se establecen los aspectos conceptuales relevantes para el estudio con relación a infancia, pobreza, pobreza infantil, capacidades y funcionamientos; en tercero habla de las mediciones de pobreza infantil que existen y que utilizan como unidad de análisis al niño; el cuarto presenta como se construye la metodología que propone este estudio; el quinto realiza una aplicación de la metodología al caso chileno; finalmente, el capítulo seis presenta las conclusiones de este estudio.

2. ASPECTOS CONCEPTUALES

2.1. Primera infancia y su importancia

Según el Artículo 1ro de la Convención de los Derechos del Niño, se entiende por niño a todo aquel ser humano menor de dieciocho años, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

La infancia puede ser clasificada en cuatro etapas: los niños entre los 0 y 5 años estarían transcurriendo la infancia temprana (o primera infancia), entre los 6 y 10 años la infancia, entre los 11 y 14 años la adolescencia temprana y, finalmente, entre los 15 y 17 años la adolescencia (Biggeri, 2006). En cada una de estas se desarrollan hitos importantes en torno a la formación de habilidades del niño.

Este estudio se centra en los niños entre 0 y 5 años, debido a que las experiencias tempranas tienen una influencia poderosa en el desarrollo de las habilidades cognitivas y sociales y en la arquitectura cerebral y neuroquímica del ser humano, dando paso a procesos neurofisiológicos que definen parte importante la naturaleza y la amplitud de las capacidades adultas (Knudsen, 2016).

El desarrollo del cerebro es un proceso muy complejo que se inicia muy temprano en la vida (Volpe, 2008). Un 80% del desarrollo cerebral ocurre en los primeros tres años de vida siendo el eje central del desarrollo integral de una persona, es en este período en donde ocurren los eventos más importantes del desarrollo fisiológico. En los siguientes dos años se desarrolla un 10% más, es decir, hasta los cinco años el cerebro se ha desarrollado en un 90%.

El proceso neurofisiológico involucra: el crecimiento del cerebro¹, el aumento de su peso, la proliferación neuronal, la mielinización², la creación de nuevas conexiones sinápticas y vías cerebrales³, este proceso da como resultado el desarrollo de las funciones cerebrales superiores.

¹ Según tablas antropométricas de crecimiento del perímetro cefálico, el cerebro del niño incrementa su tamaño de manera acelerada hasta los cinco años a razón de 2 centímetros cada mes entre los 0 a 3 meses de edad, 1 centímetro por mes entre los 3 a 6 meses, 0,5 cm entre los 6 a 12 meses y continúa creciendo, pero en menor medida hasta los 5 años, luego de esta edad este incremento se ralentiza durante la etapa escolar y la adolescencia para luego detener su crecimiento posterior a estas etapas (Cusminsky, 1993).

² La mielina es una proteína que recubre las neuronas y los nervios, esta permite que la información neurológica se transmita de manera rápida y eficiente.

³ Es necesario mencionar que las etapas del desarrollo del cerebro no son consecutivas, se van superponiendo y pueden ser afectadas simultáneamente por agentes externos o internos.

Adicionalmente, ocurre un proceso dinámico entre el niño y el medio que lo rodea.⁴ *“La interacción del niño y su entorno es sumamente relevante ya que incide sobre el neurodesarrollo⁵, determinando cambios en las habilidades motrices-sensoriales, cognitivas, emocionales y sociales⁶, lo que además se encuentra en relación con los funcionamientos a desarrollar, así como con la estabilidad psicológica afectiva-emocional, las respuestas físicas a los estímulos y los comportamientos sociales”* (UNICEF, 2011).

Cada una de las áreas de desarrollo del niño se encuentran interrelacionadas, por ejemplo, cuando el niño está expuesto a estímulos positivos y se siente amado su desarrollo emocional se ve favorecido, esto a su vez produce altos niveles de serotonina, lo que aumenta el número de conexiones sinápticas mejorando su aprendizaje. Pero si por ejemplo, el niño no se siente amado o se ve enfrentado a situaciones estresantes la hormona del cortisol se eleva, lo que impide la transmisión de serotonina al cerebro anulando su aprendizaje (Berger, 2007).

Existe una amplia literatura que establece que los ambientes de la primera infancia impactan sustancialmente los resultados de la vida posterior (e.g. Knudsen et al. (2016), Heckman (2008), Heckman, (2013), Almond y Currie (2011)). En esa línea la teoría ecológica de Bronfenbrenner (1994), define microsistema a aquel entorno inmediato con el que el niño interacciona, como por ejemplo su familia o la escuela, pero también existen otros subsistemas (mesosistema, exosistema, macrosistema y cronosistema) compuestos por elementos del medio ambiente (su barrio, redes sociales, entre otras) que también influyen en su desarrollo. Así la pobreza podría darse como parte de uno de estos subsistemas afectando el desarrollo del niño por la vía de sus relaciones y procesos más cercanos.

Recapitulando, la primera infancia es una etapa clave en el desarrollo del niño y es en esta etapa en donde se forman capacidades y funcionamientos iniciales que lo acompañarán durante su vida. Existen diversos factores como la relación con su familia y su entorno que llevarán a que el niño desarrolle de una manera favorable o no, sin embargo, cuando el niño esté expuesto a situaciones desfavorables es necesario tomar medidas inmediatas para subsanarlas y así permitir que el niño pueda desarrollarse adecuadamente; puesto que, según indica Cunha (2005), la remediación posterior de entornos desfavorecidos es mucho menos efectiva que la provisión de experiencias que promueven el crecimiento en una etapa temprana de la vida.

⁴ A lo que se denomina: plasticidad cerebral, que es la capacidad de las neuronas para adaptarse a los cambios, y regenerarse en caso necesario anatómicamente y funcionalmente con el objetivo de conseguir una mejor adaptación al medioambiente (Narbona, 2012).

⁵ El desarrollo de la infancia en sus ámbitos: biosocial, cognitivo y psicosocial en Psicología de la infancia, se ve influenciado en todos los casos por el entorno (Berger, 2007).

⁶ Durante la infancia, la adquisición progresiva de habilidades es la tarea primordial del sistema nervioso y es el reflejo de esta maduración a lo que se denomina desarrollo (Iceta, 2002).

2.2. Pobreza

La pobreza se ha conceptualizado de diferentes maneras. El Banco Mundial entrega una definición asociada a las necesidades básicas⁷, donde la pobreza es la “privación pronunciada en el bienestar” tomando en cuenta varias dimensiones: bajos ingresos e inhabilidad de adquirir bienes y servicios básicos necesarios para vivir con dignidad, bajos niveles de educación y salud, acceso limitado a agua limpia y saneamiento, seguridad física inadecuada, falta de voz e insuficientes capacidades y oportunidades para mejorar la vida propia (Banco Mundial, 2000). El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define pobreza como “la negación de opciones y oportunidades para vivir una vida tolerable” (PNUD,1997). Para Sen (1987), la pobreza es la privación de libertad para poder elegir la vida que queremos vivir.⁸

La pobreza infantil tiene características especiales que la hacen diferente a la pobreza de los adultos. En ese sentido, los niños no deben considerarse como modelos a escala de los adultos (White, 2002), por lo que se necesita un enfoque reorientado (Camfield, 2006). La especificidad de la pobreza en la infancia está dada por tres características. La primera, es que los niños son *dependientes* del cuidado de los adultos y permeables a lo que ocurra en su entorno más cercano y su familia. En segundo lugar, la pobreza es de *carácter acumulativo*, generando una mayor probabilidad de experimentar pobreza en la adultez cuando esta se experimentó en la infancia, teniendo un efecto en el largo plazo, y finalmente, el vivir la pobreza en esta etapa del ciclo de la vida puede tener *efectos irreversibles* (Espíndola, 2017).

El Fondo de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) basado en el enfoque de Derechos Humanos y la CDN definen pobreza infantil como la privación de una serie de aspectos materiales, sociales, de apoyo y servicios que son esenciales para garantizar el bienestar del niño. En “*El Estado de los Niños del Mundo*” (UNICEF, 2005) se entrega la siguiente definición: “Los niños que viven en la pobreza experimentan la privación de recursos materiales, emocionales y espirituales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar; su ausencia o déficit les impide disfrutar de sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos de derechos en la sociedad”.

The Childhood Poverty Research and Policy Centre (CHIP)⁹ indica que: La pobreza infantil significa que los niños y jóvenes crecen sin acceso a los diferentes tipos de recursos económicos, sociales, culturales, físicos, ambientales y políticos que son vitales para su bienestar y para que puedan cumplir con su potencial (CHIP, 2004 y Minujin, 2006). Esta definición implica que los niños crecen en ausencia de un

⁷ Boltvinik en 1999 se refiere a la *necesidad* como un término imprescindible para hablar de pobreza.

⁸ Para ejemplificarlo podemos tomar el caso de dos personas que tienen hambre, una de ellas no tiene los medios necesarios para alimentarse, mientras que la otra escoge hacerlo por sus creencias religiosas, en ese caso, la primera de ellas estaría en situación de pobreza ya que no tiene la posibilidad para alimentarse, mientras que la segunda no, ya que lo hace por opción.

⁹ Es un proyecto conjunto entre Save the Children de Reino Unido y el Centro de investigación de pobreza crónica.

sustento adecuado¹⁰, de oportunidades para el desarrollo humano¹¹, sin estructuras familiares que los cuiden y protejan¹² y sin oportunidades de voz y ser escuchados.¹³

Las definiciones mencionadas presentan un vínculo explícito entre la pobreza y la violación de derechos fundamentales, además de ser fenómenos multidimensionales debido a que la privación de algún factor puede incidir en la afección en otra dimensión.¹⁴ En ese sentido, para efectos de este documento se definirá pobreza infantil cuando un niño se encuentre privado en dimensiones, relacionadas a sus derechos, que le impidan desarrollar sus capacidades y lleven a que en el futuro no puedan desarrollarse o se desarrollen de manera incompleta o insuficiente.

2.3. Capacidades y funcionamientos

Las *capacidades* son nociones de libertad en sentido positivo, es decir, guardan relación con las oportunidades reales que se tiene “y que se tendrá” con respecto a la vida que se puede llevar, mientras que los *funcionamientos* son “logros” y resultados derivados de las capacidades y están directamente relacionados con las condiciones de vida.

La diferencia entre un funcionamiento y una capacidad es similar a la diferencia entre un logro y la libertad para lograr algo, o entre un resultado y una oportunidad (Robeyns, 2003). Todas las capacidades juntas corresponden a la libertad general para poder llevar la vida que una persona valora. En ese sentido, los *logros de bienestar* pueden medirse en funcionamientos mientras que *la libertad de bienestar* se refleja en el conjunto de capacidades (Sen, 1987).

Las capacidades están en directa relación con el número de opciones que las personas tienen y la libertad de elección sobre estas opciones, las cuales contribuyen al bienestar humano (Sen, 2004). En ese sentido es posible hablar de desarrollo cuando las personas tienen la libertad de hacer uso de dichas capacidades transformándolas en funcionamientos y permitiendo así que puedan seguir el plan de vida que desearían llevar.

¹⁰ Sin acceso a recursos financieros y nutricionales para la supervivencia y el desarrollo (económico, físico, etc.).

¹¹ Oportunidades para desarrollarse como una persona sana que realizará su potencial en la vida, incluyendo las oportunidades de acceso a educación de calidad y habilidades para la vida, salud y agua, saneamiento; recursos sociales, culturales y físicos.

¹² Incluye no tener padres o tutores con tiempo para cuidarlos o no tener una familia o comunidad externa que los cuide en caso de que sus padres o tutores no puedan hacerlo.

¹³ La impotencia y la falta de voz (recursos políticos) a menudo sustentan otros aspectos de la pobreza.

¹⁴ Por ejemplo, aquellos niños que no poseen un adecuado acceso a agua potable suelen tener problemas de salud al consumir agua sucia causando diarreas u otros síntomas.

Nussbaum (2000) plantea que existen tres tipos de capacidades:

- (i) *Las capacidades básicas* son el equipamiento innato de los individuos, la base necesaria para desarrollar las capacidades más avanzadas, estas se encuentran -a veces- más o menos dispuestas para funcionar. Estas capacidades son muy rudimentarias, y no pueden ponerse en funcionamiento de manera inmediata (Nussbaum, 2000).
- (ii) *Las capacidades internas* son estados desarrollados de las mismas personas y -en la medida en que conciernen a la misma persona- son condición suficiente para el ejercicio de la función requerida. Estos estados son condiciones maduras de preparación para una función. Algunas veces, la preparación sólo requiere tiempo y madurez corporal. Más a menudo, se desarrollan solamente con el apoyo del entorno. Pero hasta cierto punto, estas capacidades se encuentran allí, y la persona puede hacer uso de ellas (Nussbaum, 2000).
- (iii) Incluso cuando la gente ha desarrollado una potencialidad (habitualmente con apoyo del mundo material y social), puede sufrir un impedimento en el funcionamiento de la misma, es por eso que existe el último tipo de capacidades, *capacidades combinadas*. El desarrollo este último tipo de capacidades requiere usualmente que existan condiciones externas favorables para poder desarrollarse y así permitir el ejercicio de la función.¹⁵

Para entenderlo de mejor manera, aplicado a la situación de los niños y niñas, podemos considerar el tener la *capacidad de la vida* como una capacidad básica que se inicia al momento del nacimiento, luego, con el desarrollo corporal se inicia el desarrollo del aparato fonador¹⁶, el que está relacionado con la producción de la voz, así cuando las cuerdas vocales se encuentren desarrolladas el niño tendrá la *capacidad de poder hablar*, siendo esta una capacidad intermedia, la que finalmente se convertirá en una capacidad combinada al interactuar con su entorno y aprender el lenguaje permitiéndole empezar a hablar.

Muchas capacidades son obra del azar¹⁷, por lo que no se puede influir de manera directa en la adquisición de dichas capacidades, sin embargo, son en estas áreas en donde el Estado debería preocuparse de brindar una *base social* para poder compensar las diferencias en el punto de partida de los niños y niñas. Esto permitirá que los niños puedan desarrollar capacidades básicas y estén en plena libertad de hacer uso de las mismas convirtiéndolas en funcionamientos, teniendo la posibilidad de planificar y alcanzar la vida que esperarían tener y no siendo coartados desde una edad temprana. Como indica Nussbaum,

¹⁵ “La distinción entre capacidades internas y combinadas no es precisa, porque el desarrollo de una capacidad interna requiere usualmente de condiciones externas favorables. Efectivamente, tal desarrollo requiere a menudo la práctica real de la misma función. No obstante, la distinción es realmente operativa, porque incluso una capacidad altamente entrenada puede resultar impedida en su funcionamiento” (Nussbaum, 2002, p. 129).

¹⁶ Es el conjunto de órganos de respiración, fonación y articulación encargados de generar y ampliar el sonido que se produce al hablar.

¹⁷ A lo que John Rawls llamaría “bienes naturales”.

“planificar la propia vida sin ser capaz de hacerlo en formas más complejas es, un comportamiento humanamente incompleto” (Nussbaum, 2000, p.126).

El desarrollo humano de los niños puede ser considerado como “una expansión de las capacidades” o de “libertades positivas”. En relación con las capacidades del niño, Biggeri (2006) indica que existen al menos cinco aspectos importantes que asumen un papel central en su desarrollo.

El primer aspecto, se refiere a la capacidad de los padres, quienes pueden afectar directa o indirectamente las capacidades del niño; puede existir una especie de transferencia de capacidades entre generaciones (aunque no necesariamente las mismas). Las capacidades del niño están al menos parcialmente afectadas por el conjunto de capacidades y funcionamientos que logran sus padres, como resultado de un proceso dependiente de la trayectoria acumulada de diferentes generaciones.

En segundo lugar, en el caso de un niño, la posibilidad de convertir las capacidades en funcionamientos depende también de las decisiones de los padres, tutores y maestros lo que implica que los factores de conversión del niño están sujetos a otras limitaciones. Por un lado, los padres tienen que respetar los deseos y las libertades del niño¹⁸, pero, por otro, deben ayudar a los niños a ampliar o adquirir nuevas capacidades, incluso si se aplica como un deber. Estos dos factores pueden entrar en conflicto ya que el niño no es un actor pasivo, especialmente a medida que aumenta de edad. Por lo tanto, mientras que por un lado los niños tienen el deseo de ser autónomos¹⁹, por el otro requieren del cuidado de sus padres.

El tercer aspecto relevante, está conectado a la relación entre diferentes capacidades y funcionamientos. Aunque cada capacidad tiene un valor intrínseco, puede ser decisivo para otras capacidades. Por ejemplo, la capacidad de tener una buena salud es un fin en sí mismo, pero también es un medio para realizar la capacidad de ser educados y participar en la sociedad.

El cuarto aspecto, se refiere al ciclo de vida y la importancia de la edad en la definición de la relevancia de una capacidad. Esto implica que un niño podría tener diferentes capacidades que las de los adultos y sugiere que la relevancia de estas capacidades puede variar en función de la edad e incluso con su sexo.

Finalmente, el último aspecto se refiere al papel del niño en la construcción de futuros factores de conversión de capacidades a funcionamientos. El niño puede cambiar sus factores de conversión y, a través de la participación con otros puede modificar los factores de conversión externos, es decir, el niño puede ser al mismo tiempo el centro de una transferencia intergeneracional de capacidades y un vehículo de cambio.

¹⁸ Siempre y cuando estos no vayan en contra de su propio bienestar.

¹⁹ El grado de autonomía de elección puede variar en función de las diferentes edades, especialmente en relación con algunas capacidades.

3. MEDICIONES DE POBREZA INFANTIL

El método más utilizado para la medición de la pobreza infantil en América Latina y el Caribe es el enfoque monetario. Este enfoque, toma en cuenta el ingreso (o gasto) familiar como una medida proxy del bienestar que puede alcanzar una familia, dado que permite expresar la capacidad de consumo de bienes y servicios de los hogares reduciéndose a un denominador común, el dinero. El supuesto que está detrás de este método indirecto es que una medida monetaria puede tomar en cuenta los aspectos más relevantes de la heterogeneidad de los individuos y sus situaciones personales (Denis et al., 2010).

Este enfoque clasifica a un hogar y sus integrantes como pobres cuando el ingreso per cápita del hogar es inferior a una *línea de pobreza*, cuyo monto representa el valor monetario mínimo para satisfacer ciertas necesidades esenciales, ya sea que incluya solo el costo de adquirir una canasta básica de alimentos - basada en los requerimientos calóricos promedio de la población- o incluyendo el costo de otros bienes y servicios, expresado sobre la base de la relación entre el gasto total y el gasto de los alimentos.

Uno de los argumentos detrás de este enfoque es la existencia de un ingreso mínimo para que los individuos u hogares tengan libertad de gozar una vida decente e independiente. Sin embargo, el enfoque monetario no es adecuado para la medición de la pobreza infantil en la primera infancia debido a que los niños no son parte del mercado laboral y no tienen acceso o control sobre los ingresos de sus hogares²⁰, es por esto que hace sentido mirar qué ocurre en el hogar, a razón de que la pobreza de los niños -desde este enfoque- es producto de lo que pasa en el hogar y que estos son altamente dependientes de lo que ocurra en su entorno más cercano.

Sin desconocer que el ingreso tiene un estrecho vínculo con el bienestar material dado que expresa el potencial consumo de bienes y servicios necesarios para la satisfacción de necesidades, este consumo potencial no necesariamente se traduce en un consumo real, sumado a que ciertas necesidades no se satisfacen necesariamente por la vía del del consumo, por lo que un enfoque más apropiado para medir la pobreza infantil sería el enfoque multidimensional, basado en que al ser un enfoque directo mide el grado de necesidades satisfechas que requieren los niños y niñas para poder desarrollarse de manera adecuada.

A la fecha existen veintiséis experiencias²¹ de estimación de pobreza multidimensional en la infancia. Estos estudios consideran a los niños y adolescentes como unidad de análisis y en algunas ocasiones también

²⁰ De acuerdo al convenio sobre la edad mínima de 1973 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la edad mínima de admisión al empleo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar. Por otra parte establece que la edad mínima para trabajos peligrosos son los 18 años y ofrece una flexibilidad al permitir una edad mínima inferior para “trabajos ligeros” entendiendo a estos como aquellos trabajos que no sean susceptibles de perjudicar la salud o el desarrollo de los niños, o que no puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su participación en programas de orientación o formación profesional o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben.

²¹ *Países de América Latina y el Caribe*: Argentina 2015 (Bonfiglio y Salvia, 2015); Argentina 2013 (Tuñón y González, 2013); Colombia 2014 (Torres, 2014); Colombia 2012 (Universidad de Los Andes/UNICEF, 2012); El Salvador 2014

consideran al hogar debido a que existen dimensiones, como por ejemplo la vivienda, en donde las privaciones que pueda experimentar el niño se dan a nivel de hogar.

Entre los estudios revisados, la gran mayoría utilizan el enfoque de derechos, este se caracteriza por la consideración de los niños como *sujetos plenos de derechos* y no como *objetos de derecho* bajo la tutela del Estado; en ese sentido, se reconoce que todos los niños tienen el mismo derecho a crecer y desarrollarse plenamente, a expandir su potencialidad y a contribuir al desarrollo de la sociedad incluyendo su participación en procesos de toma de decisiones.

La Convención de Derechos del Niño, presenta un total de 54 Artículos de los cuales 42 se pueden vincular directamente a capacidades; todos independiente de su naturaleza tienen en común cuatro principios fundamentales: i) el interés superior del niño, ii) el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, iii) el respeto de sus opiniones y la participación en decisiones que les afecten, y iv) el principio de no discriminación. La CDN indica que basta que alguno de los Derechos del Niño esté ausente para que el niño se encuentre en situación de pobreza. En ese contexto, el principio del interés superior del niño obliga a considerar la superación de la pobreza en la infancia y adolescencia como prioridad.

Entre las mediciones basadas en el enfoque de derechos destaca la realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 2010, esta mide de manera estandarizada pobreza infantil en 18 países de América Latina y el Caribe²² permitiendo comparabilidad entre países. El estudio toma como unidad de análisis al niño y su hogar (dependiendo de la dimensión)²³ e incluye seis dimensiones²⁴, para cada una de ellas se establecen dos umbrales de privación, severa y moderada, correspondientes a situaciones de pobreza y pobreza extrema. Las dimensiones son: nutrición, acceso a agua potable, saneamiento, calidad de la vivienda, educación e información. Cuando un niño se encuentra privado en alguna de las tres primeras dimensiones se viola el derecho a la salud (Art. 24, CDN), ante la privación en la dimensión de vivienda se viola el derecho a tener

(STPP/UNICEF, 2014); Guatemala 2016 (ICEFI/UNICEF, 2016); Honduras 2016 (UNICEF 2016); Paraguay 2015 (Bruno y Osorio, 2015); Uruguay 2016 (Colacce y Tenenbaum, 2016); Uruguay 2008 (Amarante et al.2008). *Otros países:* Afganistán 2010 (Biggeri et al., 2010); Bangladesh 2013 (Roche, 2013); Bután 2016 (Alkire et al., 2016); China 2014 (Qi y Wu, 2014); Congo Brazaville 2012 (Notten et al, 2012); Darfur Occidental 2013 (Trani y Cannings, 2013); Egipto 2013 (UNICEF e Informal Settlements Development Facility, Egypt, 2013); India 2011 (Mohanty, 2011); Mali 2014 (de Milliano y Sudhanshu, 2014); Nigeria 2012 (Adetola y Olufemi, 2012); Papúa (Indonesia) 2013 (Ladiyanto, 2013); Tanzania 2012 (Minujin y Delamónica, 2012). *Internacionales:* África Sub Sahariana 2014 (de Milliano y Plavgo, 2014); Internacional (UNICEF) 2004 (UNICEF, 2004); Internacional (CEPAL/UNICEF) 2010 (CEPAL/UNICEF, 2010); Internacional (UNICEF CC-MODA) 2012 (de Neubourg et al., 2012).

²² Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

²³ Para la dimensión de Nutrición se considera a los niños de 0 a 4 años; para las dimensiones de agua potable, saneamiento y vivienda, consideran como unidad de análisis de la vivienda y niños y adolescentes de 0 a 17 años; para la dimensión de educación consideran a niños desde los 7 u 8 años hasta los 17; y para la dimensión de información consideran al hogar y a los niños y adolescentes de 0 a 17 años.

²⁴ Para ver los indicadores incluidos en cada dimensión junto con los respectivos umbrales de privación revisar Anexo E: Definición de indicadores y umbrales de privación severa y moderada entre los niños.

un estándar de vida (Art. 27, CDN), ante una privación en la dimensión de educación, lógicamente, el derecho violado es el derecho a la educación (Art. 28, CDN), mientras que ante una privación en la dimensión de información se viola el derecho a la información (Art. 13 y 17, CDN), es decir, esta medición considera únicamente cuatro derechos de los niños, lo que representa un 9,5% del total de los derechos que se encuentran directamente relacionados con capacidades de los niños.

Cabe recalcar que bajo el enfoque de derechos -y la medición mencionada- basta que solo un derecho haya sido violado para identificar a un niño como pobre. Es decir, se usa el enfoque de unión en la identificación, esto se explicará más adelante en la metodología.

Otros estudios consideran como base para su análisis el Enfoque de Capacidades.²⁵ Este está centrado en lo que los niños son capaces de hacer y ser, por lo que las capacidades son potenciales funcionamientos, entendiendo la pobreza infantil como la privación de capacidades básicas y funcionamientos alcanzados relacionados (Biggeri, 2012).

En ese sentido, cuando no se cumplan las condiciones básicas necesarias para un correcto desarrollo de capacidades y futuros funcionamientos de los niños y niñas, estos se verán interrumpidos teniendo repercusiones en su vida adulta, lo que lleva a la conclusión de que *“la estrategia más eficiente para (...) mejorar su calidad de vida es invertir en los entornos de niños desfavorecidos durante los primeros años de la infancia”* (Knudsen, 2006).

Una limitación del enfoque de capacidades es que es difícil medir una capacidad por igual para todos los niños debido a la etapa de desarrollo en que se encuentren, siendo que en algunos casos podría ya haberse alcanzado la capacidad mientras que en otros podría encontrarse en pleno desarrollo, es decir, el grado de desarrollo de la capacidad se encontraría directamente relacionado con la edad y el nivel de desarrollo en que se encuentre el niño. Esto lleva a la conclusión de que no es posible medir las capacidades de igual manera entre todos los niños y niñas, sino que es necesario establecer grupos etarios en función de su desarrollo.

A nivel internacional algunas de las problemáticas que tienen las mediciones de pobreza en la infancia es no miden precisamente pobreza infantil, debido a que no utilizan como unidad de análisis al niño sino más bien al hogar, por lo tanto, entregan información de aquellos hogares que se encuentran en situación de pobreza y tienen niños, pero no sobre pobreza infantil como tal.

²⁵ Otro enfoque relativamente nuevo es el Enfoque CONEVAL, este es interesante debido a que incorpora un grupo de dimensiones asociadas a derechos sociales, utiliza indicadores de carencia social y clasifica a la población en cinco grupos: población en situación de pobreza, población en situación de pobreza extrema, población vulnerable por ingresos, población vulnerable por carencias sociales, población no pobre y no vulnerable (Ver Anexo A: Metodología CONEVAL), y es utilizado para mediciones en México y Guatemala. Existen también estudios que no identifican explícitamente cuál es el enfoque teórico que utilizan para su análisis.

Por otra parte, si nos concentramos en las 26 experiencias que tienen como unidad de análisis al niño podemos ver que estas no consideran rangos de edad, obviando que los requerimientos de los niños son diferentes dependiendo de la etapa en que se encuentren y, por tanto, deben ser evaluados de manera distinta. Finalmente, cuando las mediciones utilizan un enfoque de derechos para la medición, no se abordan la totalidad de los derechos de los niños, o se reducen a considerar una cantidad de derechos muy acotada.

Para dar solución a estas problemáticas es que se propone una metodología para la medición de pobreza infantil que considere la primera infancia (0 a 5 años), que tome como unidad de análisis al niño y que utilice el enfoque de derechos y capacidades. Es fundamental que estos dos enfoques vayan de la mano, debido a que el primero revela la importancia del desarrollo de capacidades que luego se convertirán en funcionamientos y permitirán a los niños y niñas desarrollar el plan de vida que desean, y por el lado del enfoque de derechos debido a su universalidad y carácter de obligatoriedad para los Estados parte de la Convención de Derechos del Niño.

4. METODOLOGÍA

4.1. Elección de dimensiones: Selección de capacidades

Alkire (2002) propone un conjunto de consideraciones conceptuales²⁶ no excluyentes que deben cumplir las dimensiones seleccionadas para la medición de pobreza multidimensional. La primera de ellas es la *incommensurabilidad*, esta se refiere a que la sustancia de una dimensión no esté presente en la otra, y por lo tanto, no puede hablarse de ningún denominador común, siendo *irreducibles*, es decir, la lista no puede ser más corta. En tercer lugar, las dimensiones no deben ser *jerarquizables* entre sí, es decir, una dimensión no debe ser más importante que otra.

De acuerdo a Sen (2004) la elección de capacidades debe responder a dos criterios. En primer lugar, deben ser de especial importancia para la persona o grupo de interés en cuestión; y en segundo lugar, deben estar directa o indirectamente influenciadas por la sociedad. Pero a pesar de proveer estos dos criterios, no indica cuáles son o deberían ser las capacidades fundamentales²⁷, pues desde su punto de vista, establecer un conjunto de capacidades basado puramente en fundamentos teóricos es errado.²⁸

En respuesta a esta “ausencia” de capacidades Nussbaum (2000) plantea un decálogo de capacidades centrales para el funcionamiento humano, indicando que esta lista no es taxativa y está abierta a modificaciones acorde al contexto, las capacidades que plantea son: la vida; la salud corporal; la integridad corporal, los sentidos y el pensamiento; las emociones; razones prácticas; afiliación; otras especies; el juego y el control del propio entorno que incluye aspectos políticos y materiales.²⁹

Robeyns (2005) indica que al menos existen tres razones por las que no puede haber una lista final de capacidades, la primera razón es de carácter epistemológico, dependiendo del objetivo³⁰, se podría seleccionar diferentes capacidades, con diferentes limitaciones disciplinarias y parámetros válidos.³¹ La segunda razón, también de carácter epistemológico, está en relación con el poder de conocimiento; debido a que cuando el objetivo de la selección de capacidades sea utilizarlas como indicadores sociales para

²⁶ Para su desarrollo se inspira en los aportes de Manfred Max-Neff quien en sus trabajos “*La economía descalza*” y “*Desarrollo a escala humana*” trabajó en la identificación de necesidades básicas humanas para América Latina; Martha Nussbaum filósofa cuyos trabajos se encuentra relacionados principalmente con el desarrollo y la ética; y Deepa Nayanar-Parker, vocera del Banco Mundial que se destaca por trabajos como: “*The voices of the poor*”.

²⁷ Ni tampoco aporta un razonamiento sistemático sobre cómo hacer la selección.

²⁸ Uno de los argumentos del autor para no entregar una lista definida es que se debe dejar que sean los procesos democráticos y los procedimientos de elección social -las personas- quienes definan y decidan acerca de lo que será considerado como capacidades valiosas, permitiendo así que se genere un debate público acerca de qué incluir junto con su debida justificación.

²⁹ Para una definición más exacta de cada una de estas capacidades consultar Anexo B.

³⁰ Por ejemplo, en el caso de Nussbaum la elección de capacidades se pretende hacer con el objetivo de plantear una teoría filosófica moral para la construcción de una teoría normativa de la justicia, para que sea utilizada por los Estados en sus constituciones y así la justicia sea garantizada a todos los ciudadanos (Robeyns, 2005, p. 196).

³¹ Ver Anexo C: Objetivos epistemológicos, metodologías y rol de los funcionamientos y capacidades, planteados por Robeyns (2005).

mediciones de bienestar y calidad de vida mediante metodologías empíricas cuantitativas, los investigadores tendrán una perspectiva parcial de la realidad y por ende un acceso epistemológico de modo parcial dada su contextualización.³² En base a esta discusión aparecen indicios sobre la necesidad de la construcción de la lista de capacidades relevantes de manera colectiva. Finalmente, la tercera razón está en relación a preocupaciones de legitimidad, debido a que procesos de selección ilegítimos darán lugar a resultados ilegítimos.³³

Teniendo en consideración que para poder hacer una selección de capacidades se debe atender a un pensamiento democrático y que la selección debe hacerse de forma explícita y ser sometida a discusiones abiertas por los grupos involucrados para así poder eliminar prejuicios derivados de la posición social de un investigador, es que Robeyns (2003) sugiere un procedimiento para la selección que permite minimizar los posibles sesgos epistemológicos. Este procedimiento consta de cinco criterios:

1. **El criterio de la formulación explícita:** este criterio indica que la lista debe ser explícita, discutida y defendida. Este criterio a pesar de ser el más básico es fundamental debido a que usualmente en el análisis de tipo empírico cuantitativo se suelen utilizar parámetros que se encuentren en los datos disponibles, sin defender una lista de capacidades/funcionamientos a priori.
2. **El criterio de la justificación metodológica:** este criterio indica que se debe aclarar y analizar el método que ha generado la lista y justificarlo.
3. **El criterio de sensibilidad al contexto:** este criterio indica que el nivel de abstracción al que se presenta la lista debe ser apropiado para cumplir los objetivos para los cuales se busca utilizar el enfoque de capacidades.
4. **El criterio de diferentes niveles de generalidad:** está en relación al criterio anterior, y afirma que si la especificación apunta a una aplicación empírica, la lista debe elaborarse en al menos dos etapas:
 - a. Primero, elaborar una **lista ideal**, sin considerar ninguna limitación (diseño, datos, viabilidad socioeconómica o política, etc.).
 - b. Segundo, elaborar una **lista más pragmática** que tenga en cuenta dichas limitaciones.³⁴

³² En un contexto de investigación estos sesgos pueden derivar de la vida, los valores y la integración social del investigador influyendo en las capacidades a incluir en el estudio.

³³ Es en este punto en donde los lectores encuentran problemática la lista de Nussbaum, debido a que, si bien la autora indica que proviene de un largo proceso histórico, que está sujeta a modificaciones y no es estrictamente taxativa, al fin y al cabo, es una lista que plantea la autora y podría no ser exactamente replicada en distintos contextos de elección social.

³⁴ Tener en cuenta que las limitaciones pueden cambiar con el tiempo, por ejemplo, podría darse el caso de que en determinado momento exista una limitación por falta de conocimiento sobre un tema, pero con el tiempo se podría desarrollar el conocimiento en esa área dejando de ser una limitación.

- 5. El criterio de agotamiento y no reducción:** en donde las capacidades enumeradas deben incluir todos los elementos importantes, pero además, los elementos incluidos no deben poder reducirse a otros elementos.³⁵

Las primeras listas de capacidades para niños y niñas fueron planteadas por Di Tommaso (2003)³⁶ y Biggeri (2006), esta última cumple con las consideraciones conceptuales planteadas por Alkire (2002), responde a los criterios mencionados por Sen y cumple con los criterios de selección de capacidades planteados por Robeyns (2003).

La lista de Biggeri es importante porque además de cumplir con lo anteriormente mencionado elimina sesgos epistemológicos y posee legitimidad debido a que se basó en opiniones de niños que asistieron al “Congreso Mundial sobre el Trabajo Infantil” celebrado en Italia en mayo de 2004 (el cuadro 1 presenta el proceso de selección de capacidades durante el congreso). Esta lista por el hecho de ser legítima incorpora una visión que considera a los niños no solo como receptores de libertades, sino como *sujetos de derechos* al involucrarlos en la toma de “decisiones” y hacerlos partícipes en el proceso de seleccionar un conjunto de capacidades básicas que ellos consideran importantes y que fueron validadas mediante un proceso democrático de debate público.

Las dimensiones que se proponen en este estudio son una adaptación de la lista de capacidades para niños planteada por Biggeri³⁷; las adaptaciones se encuentran en relación a que existen dimensiones que adquieren una relevancia distinta para la primera infancia.

³⁵ Cabe recalcar que no podemos satisfacer la necesidad de uno de los componentes proveyendo una cantidad mayor de uno de los otros, todos son de central importancia y cualitativamente distintos.

³⁶ Que utiliza la lista de capacidades centrales de Nussbaum y selecciona siete de las diez capacidades para ser consideradas por los niños.

³⁷ Un supuesto necesario para que las capacidades seleccionadas por los niños sean efectivamente aquellas que son importantes para la infancia es que no haya un sesgo en los niños que las identificaron, en ese sentido, es de esperarse que este supuesto se cumpla, dado que según se indica los niños que asistieron al “Congreso Mundial sobre el Trabajo Infantil” provenían de distintas realidades.

Cuadro 1: Proceso de selección de capacidades durante el “Congreso Mundial sobre el trabajo infantil”

El primer paso para la conceptualización de las capacidades de los niños consistió en la selección (por parte de un investigador) de capacidades relevantes para el bienestar de los niños, fundamentada en trabajos previos sobre capacidades y literatura sobre infancia, junto con la justificación y vinculación de cada una de ellas a los 42 artículos sustantivos de la CDN.

El segundo paso, consistió en separar a los niños que asistieron al congreso en distintos grupos de edad y preguntarles *que* capacidades³⁸ consideraban como importantes y registrarlas si es que no estaban incluidas en el listado inicial; luego de esta identificación y conceptualización se les preguntó *cuan* importantes eran para ellos. Los niños identificaron un total de catorce capacidades como importantes o muy importantes, entre ellas se encuentran: vida y salud física, amor y cuidado, bienestar mental, integridad y seguridad física, relaciones sociales, participación, educación, protección contra la explotación económica y no económica, refugio y medio ambiente, actividades de ocio, respeto y religión e identidad, autonomía y movilidad (la que fue identificada sólo por los niños de mayor edad).

Finalmente, se les preguntó por aquellas capacidades que consideraban más importantes que un niño debería tener en su vida, siendo las más mencionadas la educación, el amor y cuidado, la vida y salud física, la protección contra la explotación económica y no económica y el ocio.

Adicional al proceso de identificación se hicieron focus group en donde los niños hicieron varias observaciones, entre estas: “que el nivel de relevancia una capacidad puede variar según la edad”, “que la autonomía aumenta a medida que aumenta la edad y que mientras menor sea la edad del niño este tiene un menor grado de libertad en las elecciones que tiene, sumado a que la autonomía para los niños más pequeños (0 a 5 años) no está presente”.

El proceso tomó en consideración ciertas medidas entre ellas: la edad de los niños, que estos puedan desprenderse de sus propias experiencias y que las preguntas planteadas puedan ser entendidas tanto en su contenido como en el idioma de cada niño, entre otros; esto con la finalidad de incluir la singularidad de cada niño y la generalidad de todos como grupo sin dejar de lado ninguna dimensión que sea relevante y que, a su vez, estas sean lo más objetivas y representativas posible.

Fuente: Biggeri et al., 2006. *Children conceptualizing their capabilities: esults of a survey conducted during the first childrens world congress on child labour.*

³⁸ Para hacer más entendible este término, se les preguntó por “oportunidades” en vez de capacidades.

La tabla 1 presenta las dimensiones que se proponen para la medición de pobreza infantil en la primera infancia junto con la relación directa e indirecta que tiene cada una de ellas con los derechos contenidos en la Convención de Derechos del Niño.

Tabla 1: Listado de capacidades, sus definiciones y relación con los Derechos de los Niños

N°	Capacidad	Definición	Artículos de la CDN	
			Relación Directa	Relación Indirecta
1	Vida y salud física	Ser capaz de estar físicamente saludable.	6, 23, 24, 25, 27	17, 19, 29, 33, 37, 39
2	Amor y cuidado*	Ser capaz de amar y formar vínculos afectivos significativos, así como ser capaz de ser protegido.	9, 18, 20, 27	3, 7, 10, 21, 22, 28, 38
3	Bienestar mental	Ser capaz de estar saludable mentalmente y poder afrontar tensiones de la vida normal.	23, 25, 27, 37	17, 19, 29, 33, 39
4	Integridad y seguridad	Ser capaz de poder ser protegido de cualquier tipo de violencia.	19, 25, 26, 37, 35	23, 24, 32, 34, 39
5	Redes sociales	Ser capaz de poder ser parte de una red social y disfrutarla, así como poder dar y recibir apoyo social.	15, 27	12
6	Participación e información*	Ser capaz de participar en la vida pública y social, y poder recibir información objetiva.	12, 13, 15, 17, 23	28
7	Educación	Ser capaz de poder educarse.	24, 28	23, 29, 32
8	Protección contra la explotación económica y no económica*	Poder ser protegido de cualquier tipo de explotación económica y no económica.	19, 32, 34, 35, 36	33

(continuación)

N°	Capacidad	Definición	Artículos de la CDN	
			Relación Directa	Relación Indirecta
9	Refugio y medio ambiente	Ser capaz de ser protegido y vivir en un ambiente saludable y seguro.	27	24
10	Actividades de ocio y juego	Ser capaz de poder participar en actividades de ocio y juego.	31	-
11	Respeto	Ser capaz de ser respetado y tratado con dignidad.	16, 19, 23, 30, 39	2, 27, 40
12	Identidad*	Ser capaz de tener y elegir vivir o no bajo una determinada identidad.	7, 8, 14, 29, 30	2, 27
13	Tiempo autónomo*	Ser capaz de ejercer autonomía en la asignación de tiempo y llevar a cabo proyectos.	31	37
14	Movilidad	Ser capaz de poder desplazarse con autonomía.	6, 23, 24, 27	31

Fuente: Adaptación en base a Biggeri et al. 2006 y la Convención de Derechos del Niño.

*Capacidades que pueden adquirir mayor relevancia en la medida que la edad y madurez del niño aumenta.

4.2. Elección de indicadores por dimensión

Para la elección de los indicadores se revisaron las 26 experiencias que estiman pobreza multidimensional en la infancia³⁹ y se analizó si los diversos indicadores -considerados en dichos estudios- guardan relación con las capacidades planteadas en este trabajo, y si su medición es coherente con la primera infancia. Los indicadores que cumplen estos criterios fueron incluidos, sin embargo, hubo dimensiones que nunca habían sido utilizadas anteriormente, debido a que no se suelen aplicar o son medibles para niños de mayor edad, en dichas ocasiones se recurrió a la literatura para plantear -en la medida de lo posible- indicadores que fueran adecuados y permitan ver el grado de privación en las capacidades.

³⁹ Se consideró sólo aquellas que toman como unidad de análisis al niño.

Las dimensiones con sus respectivos indicadores se encuentran en la tabla 2 a continuación:

Tabla 2: Dimensiones e indicadores por dimensión

N°	Dimensión	Indicadores
1	Vida y salud física	Vacunación e inmunización: La vacunación e inmunización es un componente esencial del derecho humano a la salud, gracias a esta el número anual de decesos de niños menores de cinco años a nivel mundial ha disminuido alrededor de 2 millones entre los años 2000 y 2010. La inmunización en el caso de los niños cobra especial relevancia debido a que los niños inmunizados y protegidos de amenazas prevenibles mediante la vacunación tienen la oportunidad de desarrollarse y más posibilidades de aprovechar su potencial (OMS, 2013). Acceso a servicios de salud: Se pueden considerar desde la etapa prenatal incluyendo los controles de salud periódicos de la madre embarazada, la asistencia calificada al parto, así como también los servicios preventivos, promocionales, de curación y de rehabilitación durante todo el ciclo de vida del infante, es decir, tener acceso y cobertura de salud posterior al nacimiento. Alimentación y nutrición: Se debe tener en cuenta la calidad, acceso y cantidad de alimentos necesarios, así como la cantidad de comidas al día y si el consumo de alimentos es dependiente de ayuda humanitaria (según sea el caso). Medidas antropométricas: Dentro de las medidas antropométricas la más conocida se refiere a la malnutrición, la cual incluye tanto la desnutrición por déficit de micronutrientes (Vitaminas y minerales como: hierro, vitamina A, cinc, ácido fólico, yodo, etc.) así como también la obesidad por exceso de macronutrientes.⁴⁰ Presencia de enfermedades: Dentro de las cuales se consideran también las deficiencias, discapacidades y minusvalías como enfermedades de acuerdo con la

⁴⁰ Es necesario mencionar que la desnutrición es la mayor causa de mortalidad infantil en edad la capacidad de respuesta a las diferentes infecciones, produce problemas de ceguera y aumenta hasta en un 25% el riesgo de mortalidad infantil. La falta de yodo es el principal motivo de retardo mental y aminora el coeficiente intelectual en casi 10 puntos (CEPAL/UNIEC, 2010).

N°	Dimensión	Indicadores
		clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la salud, CIE-10 (OPS, 2003).
2	Amor y cuidado	Expresiones de amor: La importancia de este indicador radica en las emociones del niño. Si a un niño se le hace cariño siempre, si se le transmite con gestos y palabras lo importante que es para sus padres y familiares, aprenderá que es una persona valiosa y caminará seguro por la vida (UNICEF, 2000), además de generar un apego seguro con sus padres o cuidador. Quien se hace cargo del niño: Este indicador se relaciona a si hay adulto responsable que lo cuide, si permanece solo en casa y/o es dejado a cargo de menores. Estimulación temprana: Puede medirse en base a si sus cuidadores le leen cuentos o enseñan cosas.
3	Bienestar mental	En esta dimensión se encontró únicamente indicadores para niños mayores de 6 años, que incluyen preguntas directas en relación a cómo se siente el niño, sin embargo, recurriendo a la literatura ⁴¹ es posible plantear el indicador de presencia de patologías (como la depresión infantil y el déficit atencional) las cuales se pueden operacionalizar mediante conductas internalizantes y externalizantes.
4	Integridad y seguridad	Los indicadores de esta dimensión se relacionan principalmente con el maltrato ⁴² , por lo que el indicador que corresponde para su medición es la forma de castigo de la madre, padre o cuidador .

⁴¹ Ver Spitz (1949) y Campbell (1986). Estos estudios asocian además la relación que existe entre el cuidador del niño con la presencia de estas patologías.

⁴² UNICEF define como víctima de maltrato y abandono a aquellos niños, niñas y adolescentes que “sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales”. Las consecuencias del maltrato infantil se hacen visibles a mediano y largo plazo en el desarrollo psicosocial y físico de las personas (UNICEF, 2010). De hecho, si tomamos en consideración teorías conductistas del desarrollo humano, en particular la teoría cognoscitiva social de Bandura (1918), quien centra su interés en el estudio de la agresividad infantil como conducta adquirida e indica que los niños aprenden a comportarse mediante la observación y la imitación de la conducta violenta de sus padres; podemos llegar a la conclusión que un niño al verse expuesto a cualquier tipo de maltrato en su infancia, además de sufrir daños emocionales es probable que herede esta conducta violenta y la exprese en su adultez reproduciendo violencia física o psicológica hacia sus parejas y/o hijos.

(Continuación)

N°	Dimensión	Indicadores
		A pesar de no incluirse en otros estudios de pobreza infantil, se sugiere incorporar como indicador el reporte de <i>spanking</i> (palmadas), que puede ser entendido como un patrón de violencia legalmente permitido. ⁴³
5	Redes sociales	Red de personas que entreguen apoyo social y/o tener a quienes recurrir en caso de eventualidades. Este indicador no se encuentra explícito ningún estudio de pobreza infantil, sin embargo, es similar a los umbrales establecidos en la dimensión de redes y cohesión social que utiliza Chile para la medición de pobreza multidimensional.
6	Participación e información	Acceso a medios de información: Computador, internet, libros, teléfono (fijo o celular), televisor, radio, etc.
7	Educación	Acceso a recursos educativos: Música, libros infantiles, etc. Acceso a sistemas educativos: Una vez que el niño cumpla el mínimo de edad para asistir a la educación preescolar. ⁴⁴ Educación de los padres: Dado que existe evidencia significativa de que la educación de los padres influye positivamente en la estimulación cognitiva de los niños y puede ser considerado como un factor de transferencia de capacidades entre generaciones.
8	Protección contra la explotación económica y no económica	Tareas realizadas por el niño en el hogar: Puede ser medido por tipo de actividad o por la cantidad de horas que se destinan a dicha actividad. Trabajo infantil: Puede ser medido por tipo de trabajo o por la cantidad de horas que se destinan a este.

⁴³ De acuerdo a Straus (1997) cuando los padres usan el castigo corporal para reducir la conducta antisocial del niño, el efecto a largo plazo tiende a ser contrario. El autor indica que si los padres reemplazan el castigo corporal por modos de disciplina no violentos podría reducirse el riesgo de comportamiento antisocial en los niños y el nivel de violencia en la sociedad.

⁴⁴ Algunas horas por día de educación preescolar a los 3 y 4 años promueve la competencia social, la planificación y la organización afectando de manera significativa y beneficiosa los resultados de vida (Heckman, 2013).

(Continuación)

N°	Dimensión	Indicadores
9	Refugio y medio ambiente	Estado y materialidad de la vivienda: Ya sea pisos, paredes, techo o incluso ventanas. Saneamiento: En relación al alcantarillado, sistema de eliminación de excretas, tenencia de baño y si es compartido con otros hogares. Agua potable: Atendiendo a que esta sea suficiente, segura y fácilmente accesible. Hacinamiento: Relación entre el número de personas del hogar y número de piezas para dormir. Tenencia o propiedad de la vivienda: Este indicador puede interpretarse como la tenencia de un activo de valor que puede usarse en caso de problemas o indicar la situación de regularidad en el uso de la vivienda. Entorno físico: Relacionado a si en el entorno del hogar existe crimen, contaminación, ruidos (del vecino o de la calle), la ubicación de la vivienda (si la zona es un basural permanente, un terreno inundable o hay alguna fábrica contaminante en las cercanías), y la seguridad. Recolección de basura: Si se cuenta con un servicio regular y/o la distancia entre el hogar y el punto de recolección de basura. Acceso a parques y zonas verdes en la cercanía del hogar.
10	Actividades de ocio y juego	Juego con otros niños y/o sus cuidadores. Realización de actividades: Tanto al interior⁴⁵ como al exterior del hogar. Tener un rincón de juego en el hogar: De modo que les permita jugar, crear, explorar y favorecer con ello su desarrollo.⁴⁶

⁴⁵ Las actividades al interior pueden incluir: cantar o leer libros (con la ayuda de un adulto)

⁴⁶ Este indicador surge como propuesta del Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral del Gobierno de Chile, y tiene como objetivo que los niños alcancen su máximo potencial, favoreciendo las condiciones para su desarrollo y aprendizaje integral. El programa entrega un material didáctico denominado "Rincón de Juego (RINJU)" que consiste en un habitáculo en donde el niño se imagine diversos escenarios dando paso a un juego libre o guiado por sus cuidadores.

(Continuación)

Nº	Dimensión	Indicadores
11	Respeto	Para esta dimensión no se encuentran indicadores específicos en la literatura revisada, sin embargo, se sugiere incorporar como indicador a nivel de hogar la discriminación , en el sentido de si la familia o el hogar ha sufrido tratos discriminatorios en el sector público o con sus pares en cuanto a la relación con el niño.
12	Identidad	En la literatura no existen indicadores relacionados a esta dimensión, sin embargo, se propone utilizar como indicador el estar registrado en el Registro Civil y contar con un certificado de nacimiento. ⁴⁷
13	Tiempo autónomo	En la literatura existen indicadores como el <i>bañarse, vestirse, prepararse alimentos, ir al baño, comer y beber</i> que son utilizados para medir autonomía. Sin embargo, dada la edad en estudio (0 a 5 años) y que los niños durante esta etapa no tienen incidencia en el uso de su tiempo para realizar estas actividades, es que se opta por no considerar la dimensión –y por consiguiente sus indicadores- en la medición de pobreza infantil.
14	Movilidad	En la revisión de la literatura existe únicamente un estudio realizado en Afganistán (Biggeri, 2010) que incluye indicadores para movilidad, estos son: subir escaleras, ir a la tienda, llevar agua, trabajar en el campo y manejar una bicicleta o un animal. Sin embargo, considerando que los niños entre 0 y 5 años aún no pueden realizar estas actividades es que se sugiere utilizar el indicador sobre la realización de movimientos autónomos de acuerdo a hitos para la edad.

⁴⁷ Este indicador se encuentra directamente relacionado con el Art. 7 de la CDN, el cual indica que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir nacionalidad y en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

4.3 Unidad de análisis

Dado que el estudio propone una metodología para la medición de pobreza infantil, la unidad de análisis es el niño, sin embargo, el niño dada su edad y que aún es dependiente de su entorno, hay dimensiones que deben ser medidas a nivel de hogar. A continuación, en la tabla 3 se indica la unidad de análisis para cada una de las dimensiones.

Tabla 3: Unidad de análisis de acuerdo a cada dimensión

N°	Dimensión	Unidad de análisis
1	Vida y salud física	Niño(a)
2	Amor y cuidado	Niño(a)
3	Bienestar mental	Niño(a)
4	Integridad y seguridad	Niño(a)
5	Redes sociales	Hogar
6	Participación e información	Hogar
7	Educación	Niño(a) y hogar
8	Protección contra la explotación económica y no económica	Niño(a)
9	Refugio y medio ambiente	Hogar
10	Actividades de ocio y juego	Niño(a)
11	Respeto	Hogar
12	Identidad	Niño(a)
13	Movilidad	Niño(a)

4.4 Criterios de identificación

La identificación es la etapa que responde a la pregunta: ¿quién es pobre?; para realizar la estimación y responder a esta pregunta se sigue la metodología planteada por Alkire y Foster (2011)⁴⁸, que proponen un enfoque dual el cual establece dos umbrales de corte. El primer umbral corresponde a la línea de pobreza (z_i) de cada dimensión o indicador, y el segundo umbral se encuentra determinado por el porcentaje (k) de dimensiones o indicadores en los que un niño debe encontrarse privado para ser considerado como pobre multidimensionalmente.

Para el establecimiento de porcentajes de privación (k) la literatura establece que existen dos enfoques, el de unión y el de intersección. El enfoque de *unión* considera que basta identificar una privación en una

⁴⁸ El estimador propuesto por Alkire y Foster es una generalización de las medidas unidimensionales de pobreza (FGT) propuestas por Foster-Greer-Thorbecke (Foster et al., 1984).

dimensión o indicador para que el niño se considere privado; y el enfoque de *intersección* que indica que debe existir privación en todas las dimensiones o indicadores para que el niño se considere privado.

El modelo usa la función de identificación propuesta por Bourguignon y Chakravarty (2003), y sirve como base para el método de Alkire y Foster. Se describe a continuación:

$$\rho_k(x_i, z) = \begin{cases} 1 & \text{si } \theta_i(x_i, z) \geq k \\ 0 & \text{si } \sim \end{cases}$$

Donde ρ_k son las distintas dimensiones y θ_i son los distintos indicadores, en donde se toma el valor 1 si existe privación y 0 si no existe privación. Y donde la matriz de privaciones $g_\alpha(K)$ de $n \times m$ cuando $\alpha \geq 1$ se da de la siguiente forma:

$$g_\alpha(k)_{ij} = \begin{cases} \left(1 - \frac{x_{ij}}{z_j}\right)^\alpha & \text{si } x_{ij} < z_j \text{ y } \rho_k(x_i, z) = 1 \\ 0 & \text{si } \sim \end{cases}$$

Esta matriz tiene una fila de ceros para aquellos niños que no son pobres multidimensionalmente y para los que sí lo son tiene la brecha de pobreza para cada dimensión en la que se encuentren por debajo del umbral.

Se debe considerar que no es posible definir una línea de pobreza, dado que al tratarse de una medición bajo el enfoque de derechos si se estableciera una línea significaría que se le da mayor relevancia a determinados derechos, lo cual iría en contra del enfoque que indica que basta que un solo derecho se encuentre privado para ser considerado pobre, por esto último que se considera al enfoque de unión para la identificación de privaciones.

Es necesario mencionar que en este estudio no se establecen líneas de pobreza para cada uno de los indicadores propuestos, debido a que se propone una metodología ideal lo suficientemente flexible para que pueda ser aplicada a la realidad de cada país en función de la normativa vigente y la disponibilidad de datos que con que se cuente.

4.5 Orden de agregación

La agregación responde a la pregunta: ¿Qué tan pobres son los niños?, para responder a esto se utilizan los indicadores H , A y M_0 propuestos por Alkire y Foster (2011).

Índice de Recuento (H)

El índice de recuento estima la proporción de personas en la sociedad que han sido identificadas como pobres.

$$H = \frac{q}{n}$$

Donde q es el número de niños que sufren $x\%$ de privaciones y n corresponde al total de niños en edades entre los 0 y 5 años.

Intensidad de la pobreza (A)

Este índice proporciona información sobre la profundidad de las privaciones que experimentan los niños pobres, para eso se calcula un vector censurado de privaciones $C_i(k)$, que cuenta las privaciones para cada niño que fue identificado como pobre. Luego, se calcula de la siguiente manera:

$$A = \sum_{i=1}^n C_i(k) / q$$

Así, A representa el porcentaje promedio de indicadores ponderados de las privaciones de los niños que son identificados como pobres.

Tasa de recuento ajustada (M_0)

Este índice entrega información sobre la proporción de pobres y sus niveles de privación conjuntos. Y se calcula como:

$$M_0 = H \times A$$

Además M_α no solo tiene en cuenta los niveles de privación (cuando $\alpha = 0$), sino que también puede entregar la profundidad de las privaciones cuando toma el valor de $\alpha = 1$, siendo M_1 la brecha de pobreza ajustada, o puede explicar la desigualdad de las privaciones entre los pobres cuando $\alpha = 2$.

$$M_\alpha(x, z) = \frac{1}{nd} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^d w_j (g_\alpha(k)_{ij})^\alpha$$

5. CASO CHILENO

5.1 Mediciones de pobreza en Chile

En Chile la medición de la pobreza está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y se mide a nivel de hogares basado en datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN). Entre 1987 y 2013 se utilizaba el enfoque monetario para la estimación, sin embargo, desde el año 2014 se incorporó la medición de pobreza multidimensional, la que consideraba cuatro dimensiones: educación, salud, trabajo y seguridad social y vivienda; y en 2015 se incorporó una quinta dimensión: redes y cohesión social. Cada una de estas dimensiones tiene una ponderación de 22,5% a excepción de la última dimensión incorporada que tiene una ponderación de 10%.

Las mediciones de pobreza de hogares basadas en la encuesta CASEN para el año 2017, indican que un 13,9% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) se encuentran en hogares en situación de pobreza por ingresos y un 22,9% de los NNA se encuentran hogares en situación de pobreza multidimensional, considerando que hay un 43,5% de hogares con que tienen NNA de 0 a 17 años.

En cuanto a mediciones de pobreza infantil para Chile⁴⁹, existe únicamente el estudio realizado por CEPAL y UNICEF el año 2010. Este estudio se realizó en 18 países, entre los cuales se encuentra Chile. El estudio consideró dimensiones estándar para poder tener comparabilidad internacional. Los datos que utilizaron provienen de la encuesta CASEN del año 2006 y del Censo de población y vivienda del año 2002.

Los resultados muestran que Chile se encuentra mejor posicionado en comparación a los otros países estudiados para la gran mayoría de indicadores, es más, es clasificado dentro de los países con menor pobreza infantil, categoría en donde sólo se incluyen a aquellos países en los que el 8% (o menos) de los niños se encuentran en situación de pobreza.

Por otra parte, Denis et al. (2010) realiza dos estimaciones de pobreza multidimensional para Chile utilizando la metodología de Alkire y Foster (2011) y la metodología CONEVAL (ver Anexo A), en base a la encuesta CASEN del año 2006. Ambos estudios fueron aplicados a tres subgrupos de la población: menores de 15 años, población económicamente activa y adultos mayores. Para la población menor de 15 años consideraron cuatro indicadores: educación, salud, vivienda e ingresos.⁵⁰ Denis et al. (2010), encuentra los resultados que se exponen en a continuación en la tabla 4:

⁴⁹ En el Anexo D se incluye una breve reseña de cuáles han sido los avances del país en materia de derechos e institucionalidad en la infancia.

⁵⁰ Para la dimensión de ingresos utiliza tres posibles indicadores. Una línea de pobreza absoluta (utilizada por el MIDEPLAN, basada en los cálculos de CEPAL), una línea de pobreza actualizada propuesta por Larraín y una línea de pobreza relativa. Para efecto de mostrar los resultados, en este estudio se considera la línea de pobreza absoluta.

Tabla 4: Resultados bajo la metodología de Alkire y Foster (2011), para menores de 15 años encontrados por Denis et al. (2010)

Identificación de pobreza multidimensional	Índice de recuento (H)	Tasa de recuento ajustada (M0)	Educación	Salud	Vivienda	Ingresos
Enfoque de unión	55,8%	19,9%	8,7%	21,9%	42,8%	26,5%
Enfoque de intersección	0,2%	0,2%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%

Fuente: Denis et al. 2016, p. 127-128.

Bajo la metodología CONEVAL (ver Anexo A) el índice de recuento es de 14,5%, la intensidad es 41% y la tasa de recuento ajustada es 5,9%. Las tres medidas para el grupo multidimensionalmente pobre.

5.2. Aplicación para Chile

Para la estimación de pobreza infantil en la primera infancia desde un enfoque de derechos y capacidades para Chile se utilizan los datos de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI). La ELPI fue desarrollada con el objetivo de incrementar la información disponible y avanzar en la conformación de datos que permitan realizar un seguimiento de la primera infancia y la evaluación de políticas públicas en este ámbito (ELPI, 2010). La encuesta busca medir distintas dimensiones del desarrollo infantil: cognitivo, motor, socioemocional, el lenguaje y la función ejecutiva. Además de los cuestionarios aplicados que recogen información sobre: los factores sociales y el medio en que se desenvuelven los niños y niñas, características de sus hogares y de su madre, padre o cuidador/a principal, también se incluyen evaluaciones tanto a los niños como a sus cuidadores principales.

El carácter longitudinal de la encuesta permite caracterizar y analizar el desarrollo de sucesivas cohortes de niños y niñas a lo largo de su infancia y adolescencia. A la fecha existen tres rondas realizadas los años 2010, 2012 y 2017.

La muestra que se utiliza para la medición incluye a niños entre 0 y 5 años de edad cumplidos, siendo un total de 4114 niños, de los cuales la gran mayoría se incorporaron en la muestra del 2017. En la tabla 5 se presentan las edades de los niños que componen la muestra.

Tabla 5: Edad de los niños que componen la muestra

Edad en años	Frecuencia
Menores de 1 año	3
1 año cumplido	556
2 años cumplidos	848
3 años cumplidos	923
4 años cumplidos	898
5 años cumplidos	886
Total	4.114

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ELPI.

La metodología que se propone se aplica con la única salvedad de que dada la riqueza de la muestra fue posible construir cada uno de los indicadores con varias variables relacionadas.⁵¹

Para la identificación, se utilizó el enfoque de unión. Esto debido a que basta que alguna de las variables o indicadores se encuentre en situación de privación para que algún derecho se encuentre violado.

Los umbrales de privación para cada una de las variables utilizadas pueden encontrarse en el Anexo F, este anexo también incluye el porcentaje de privación del total de los niños y el número de observaciones que poseen cada variable. Es necesario mencionar que en aquellas observaciones en donde la respuesta fue “no sabe”, o “no responde” no se hizo ningún supuesto con respecto si se encontraba privado o no, simplemente se consideró como dato perdido y no se tomó en cuenta para el índice de recuento.

Algunas de las dificultades en la aplicación de la metodología fue que algunas variables utilizan distintos umbrales dependiendo de la edad de los niños y la existencia de variables que se aplicaban recién a partir de cierta edad (por construcción de la encuesta), sólo en este último caso, se consideró como no privados a los niños menores de edad de aplicación de la variable.

Por otra parte, en los datos no se encuentran variables o indicadores que sean aplicables a la primera infancia en las siguientes dimensiones: protección contra la explotación económica y no económica, respeto y movilidad, es por esto que no se tomaron en cuenta en la estimación.

La tabla 6 muestra los pesos para cada uno de los indicadores que componen las dimensiones. Los pesos son repartidos de manera equitativa entre dimensiones y entre indicadores que comparten cada dimensión.

⁵¹En el caso de que el indicador contase con una única variable para su medición, el umbral de privación se estableció a nivel del indicador.

Tabla 6: Dimensiones, indicadores y pesos

Dimensión	Peso dimensión	Indicadores	Peso indicador
Vida y salud física	0,1	Vacunación e inmunización	0,02
		Acceso a servicios de salud	0,02
		Alimentación y nutrición	0,02
		Medidas antropométricas	0,02
		Presencia de enfermedades	0,02
Amor y cuidado	0,1	Amor y atención	0,03
		Cuidado	0,03
		Estimulación temprana	0,03
Bienestar mental	0,1	Evaluaciones socioemocionales	0,10
Redes sociales	0,1	Compañía durante el embarazo	0,10
Integridad y seguridad	0,1	Violencia reportada	0,05
		Violencia observada	0,05
Participación e información	0,1	Acceso a medios de información	0,10
Educación	0,1	Acceso a sistemas educativos	0,05
		Educación de los padres	0,05
Refugio y medio ambiente	0,1	Materialidad vivienda	0,01
		Saneamiento	0,01
		Agua potable	0,01
		Hacinamiento	0,01
		Propiedad de la vivienda	0,01
		Cercanía de servicios	0,01
		Entorno físico en la cercanía del hogar	0,01
Actividades de ocio y juego	0,1	Juego con cuidadores	0,05
		Actividades en el exterior	0,05
Identidad	0,1	Registro Civil	0,05

5.3. Construcción de indicadores

Vida y salud física

Los indicadores y variables que componen esta dimensión son:

- *Vacunación e inmunización*: se consideraron todas aquellas vacunas que eran obligatorias para la edad del niño de acuerdo al Calendario de Vacunación del año 2017 establecido por el Ministerio de Salud.

- *Acceso a servicios de salud:* compuesto por el tipo de sistema previsional, el número de visitas al médico que realizó la madre durante el embarazo y el número de controles con un médico general o pediatra que realizó el niño de acuerdo a su edad.
- *Alimentación y nutrición:* estado nutricional, diagnóstico de exceso de peso, si fue amamantado, consumo de proteínas⁵² (pescados, mariscos o legumbres), consumo de frutas y verduras⁵³, consumo de lácteos.⁵⁴
- *Medidas antropométricas:* peso para la edad⁵⁵, talla para la edad e índice de masa corporal.
- *Presencia de enfermedades:* este indicador toma como variables clasificaciones de enfermedades de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud. Para ver qué enfermedades se incluyen en cada clasificación consultar el Anexo G. Las clasificaciones son: cáncer, enfermedades crónicas, del desarrollo, hereditarias, malformaciones, mentales y otras.

Amor y cuidado

Los indicadores y variables que componen esta dimensión son:

- *Amor y atención*⁵⁶: el cuidador le habla al niño al menos dos veces, el cuidador le da al niño besos, caricias, o abrazos al niño/a, al menos una vez, el cuidador contesta verbalmente a preguntas o peticiones del niño, el cuidador le transmite al niño sentimientos positivos.
- *Cuidado:* el niño se quedó solo en casa o al cuidado de otro niño, exposición del niño al humo de tabaco, uso de medidas de seguridad al ser transportado en auto (cinturón de seguridad, sillita de seguridad o alzador de seguridad).
- *Estimulación temprana:* alguno de sus cuidadores le canta (incluyendo canciones de cuna), le enseñan⁵⁷: los animales y sus sonidos, los colores, los números, las letras; le cuentan, leen o miran dibujos de un cuento o libro con figuras; le nombran, cuentan o dibujan cosas al niño.

⁵² En mayores de 2 años (por construcción de los datos).

⁵³ En mayores de 2 años (por construcción de los datos).

⁵⁴ En mayores de 2 años (por construcción de los datos).

⁵⁵ Esta variable se usa para evaluar si un niño presenta: bajo peso y bajo peso severo, pero no se usa para clasificar a un niño con sobrepeso y obesidad.

⁵⁶ Reportes de acuerdo a observaciones del evaluador de la ELPI durante la visita.

⁵⁷ Para enseñanza se considera a partir de los 3 años.

Bienestar mental

El indicador en esta dimensión es llamado *evaluaciones socioemocionales* y está compuesto por variables que provienen del test Child Behavior Checklist (CBCL), este test es utilizado para identificar comportamiento problemático en los niños, ya sean conductas internalizantes o externalizantes. Las variables que se incluyen son: Reactividad emocional, ansiedad o depresión, quejas somáticas, autismo/ensimismamiento, problemas del sueño, problemas del sueño y conductas agresivas.⁵⁸

Integridad y seguridad

Los indicadores y variables que componen esta dimensión son:

- *Violencia reportada*⁵⁹: medidas de violencia física⁶⁰, violencia psicológica⁶¹ en el hogar y observar/presenciar peleas ente integrantes del hogar.
- *Violencia observada*⁶²: si el cuidador principal golpea o expresa hostilidad hacia el niño durante la visita.

Redes sociales

El indicador que compone esta dimensión y sus variables son:

- *Compañía de la madre durante el embarazo*⁶³: las variables utilizadas son si la madre tuvo compañía en los controles durante el embarazo y si estuvo acompañada durante el parto.

Participación e información

El indicador que compone esta dimensión y sus variables son:

- *Acceso a medios de información*: el conocimiento del programa Chile Crece Contigo⁶⁴ y la tenencia de un computador, tablet o teléfono celular conectados a internet.

⁵⁸ Estas variables son categorías diagnósticas según el Manual Diagnóstico y Estadístico de trastornos mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría.

⁵⁹ Es una medida reportada dado que fueron medidas utilizadas en el niño como método para afrontar un problema de comportamiento por parte del cuidador. Esta variable sólo se considera para niño mayores de 5 años (por construcción de los datos), los menores de esa edad son considerados como no privados.

⁶⁰ Sacudidas, palmadas o golpes en el trasero, golpes en algún lugar del cuerpo con un cinturón palo u otro objeto duro; golpes o palmadas en la cara, cabeza u orejas; palmadas en la mano, brazo o piernas; palizas (golpes una y otra vez).

⁶¹ Quitar algún privilegio; retar gritando; llamó al niño tonto, flojo o algo parecido; lo ignoró; lo amenazó; o lo mando a un lugar donde estar solo por un rato.

⁶² Reportes de acuerdo a observaciones del evaluador de la ELPI durante la visita.

⁶³ Las variables usadas sólo se preguntaron a las madres de la muestra del 2017, aquellas que provenían de la muestra de panel se las consideró como no privadas.

⁶⁴ Subsistema Intersectorial de Protección Integral de la infancia, también creado el año 2009. Su misión es acompañar, proteger y apoyar de forma integral a todos los niños, niñas y sus familias por medio de acciones y servicios de carácter universal, y de un apoyo particular para aquellos que presenten alguna vulnerabilidad mayor.

Educación

El indicador y las variables que componen esta dimensión son:

- *Acceso a sistemas educativos:* existencia de un centro educacional cercano al hogar o lugar de trabajo del cuidador, asistencia a un centro educacional⁶⁵ y la educación de los padres.⁶⁶

Refugio y medio ambiente

Los indicadores que componen esta dimensión son:

- *La materialidad de la vivienda.*
- *Saneamiento (o sistema de eliminación de excretas).*
- *Agua potable.*
- *Hacinamiento.*
- *Propiedad de la vivienda.*
- *Cercanía de servicios.*
- *Entorno físico en la cercanía del hogar:* las variables que componen este indicador son la existencia de contaminación de cualquier tipo en el entorno cercano del hogar; acumulación de basura; existencia de plagas, animales peligrosos o abandonados; personas consumiendo drogas o alcohol en la vía pública, personas peleando o amenazándose en la vía pública, balaceras o disparos de armas de fuego, asaltos y robos de propiedad.

⁶⁵ De acuerdo a la Ley N° 20.710, la obligatoriedad de asistencia existe únicamente a partir de nivel de transición mayor (kínder) cuya edad mínima de ingreso es a los cinco años, sin embargo, en este estudio consideramos que si un niño a partir de los dos años no es enviado se encuentra privado debido a que la asistencia a un centro educacional favorece el desarrollo socioemocional de los niños.

⁶⁶ Para esta variable se considera la edad de los padres y la cantidad de años de escolaridad obligatorios de acuerdo a la reforma educacional que se encontraba vigente en la época. La reforma de 1920 establecía un mínimo de 4 años escolaridad, la reforma de 1929 establecía un mínimo de 6 años de escolaridad, la reforma de 1965 establecía un mínimo de 8 años de escolaridad, y finalmente, la reforma de 2003 establece un mínimo de 12 años de escolaridad.

Actividades de ocio y juego

Los indicadores que componen esta dimensión son:

- *Juego con los cuidadores.*
- *Actividades al exterior:* las variables que componen este indicador son paseos a parques, plazas, ludotecas juegos públicos; y paseos a museos, zoológicos, bibliotecas u otro paseo cultural.

Identidad

Los indicadores que componen esta dimensión son:

- *Estar registrado en el Registro Civil.*
- *Identificación del niño con su nombre y/o apellido.*

5.4. Análisis y resultados

La tabla 7 presenta las medidas de distribución de los indicadores del método de Alkire y Foster (2011). Para la estimación de estas se consideran solo aquellos niños que poseen datos para todas sus variables e indicadores, por lo que solo se estimó un 77,3% del total de la muestra, lo que equivale a 3183 niños.

Como se argumentó anteriormente, al no poder establecer un umbral de corte de pobreza multidimensional desde un enfoque de derechos y capacidades por el hecho de que las capacidades no pueden ser jerarquizables entre sí, sumado además a que el establecimiento de un umbral daría la posibilidad a que existan derechos que estén siendo quebrantados pero que aún así el niño pueda no sea identificado como pobre (dependiendo del k que sea escogido).

El elegir no establecer de una línea de pobreza (k) no permite desagregar la información para saber cuáles son las dimensiones censuradas que poseen mayores niveles de privación, sin embargo, se presentan diferentes umbrales de privación (k) con lo que se puede hacer un análisis de manera agregada. Por ejemplo, en la tabla 7 se puede ver que a partir de un umbral de corte de $K=60$ no es posible encontrar niños que estén privados. Es necesario hacer notar que un $K=60$ implica que existe un determinado número de variables o indicadores en las que el niño se encuentre privado y que la suma de los pesos de estas variables o dimensiones mayor o igual 60%.

Tabla 7: Estimaciones de pobreza multidimensional en la primera infancia para diferentes umbrales de privación (k)

<i>k</i>	<i>H</i>	<i>A</i>	<i>M</i> ₀	Obs.
5	96,4%	22,5%	21,7%	3183
10	86,6%	24,1%	20,9%	3183
15	72,4%	26,3%	19,1%	3183
20	53,9%	29,3%	15,8%	3183
25	35,4%	33,0%	11,7%	3183
30	21,2%	36,6%	7,8%	3183
35	11,1%	40,6%	4,5%	3183
40	4,7%	45,2%	2,1%	3183
45	2,0%	49,2%	1,0%	3183
50	0,8%	52,6%	0,4%	3183
55	0,2%	57,1%	0,1%	3183
60	0,0%	0,0%	0,0%	3183
65	0,0%	0,0%	0,0%	3183
70	0,0%	0,0%	0,0%	3183
75	0,0%	0,0%	0,0%	3183
80	0,0%	0,0%	0,0%	3183
85	0,0%	0,0%	0,0%	3183
90	0,0%	0,0%	0,0%	3183
95	0,0%	0,0%	0,0%	3183
100	0,0%	0,0%	0,0%	3183

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ELPI.

Si se analiza el índice de recuento por sexo, es posible apreciar (en la tabla 8) que hay una mayor cantidad de niños en situación de pobreza en comparación a las niñas, esto ya que para cualquier línea de pobreza (*k*) que se escoja el índice de recuento siempre es mayor en niños que en niñas.

Dadas las limitaciones del modelo podemos observar (en la tabla 9) el índice de recuento bruto (no censurado), para ver cuáles son las dimensiones en donde hay un mayor nivel de niños que se encuentran privados. Las tres dimensiones con mayor porcentaje de niños y niñas privados son las de refugio y medio ambiente, amor y cuidado, y vida y salud física, con un 94%, 81% y 69% de niños privados respectivamente.

Tabla 8: Índice de recuento por sexo

K	Masculino	Femenino
5	97,2%	95,6%
10	86,9%	86,3%
15	72,8%	71,9%
20	56,3%	51,5%
25	36,7%	34,1%
30	22,2%	20,2%
35	12,6%	9,6%
40	5,9%	3,5%
45	2,8%	1,3%
50	1,3%	0,2%
55	0,3%	0,0%
60	0,0%	0,0%
65	0,0%	0,0%
70	0,0%	0,0%
75	0,0%	0,0%
80	0,0%	0,0%
85	0,0%	0,0%
90	0,0%	0,0%
95	0,0%	0,0%
100	0,0%	0,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ELPI.

Tabla 9: Índice de recuento bruto (no censurado)

Dimensión	Porcentaje de privación
Refugio y medio ambiente	94%
Amor y cuidado	81%
Vida y salud física	69%
Participación e información	43%
Bienestar mental	31%
Educación	30%
Integridad y seguridad	29%
Redes sociales	21%
Identidad	17%
Actividades de ocio y juego	8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ELPI.

Si se analiza la dimensión de refugio y medio ambiente (ver tabla 10), se observa que el indicador conflictivo es el de entorno en la cercanía del hogar, el cual indica que el hogar se encontrará privado si en los últimos 12 meses si alguna vez presencié una situación que vaya en contra de un entorno idóneo, por ejemplo: contaminación, presencia de plagas, actos vandálicos, etc.

Si la dimensión se construyese sin este indicador el porcentaje de niños que se encontrarían privados bajaría automáticamente a un 54%, la pregunta que queda abierta es si el niño o su familia puede tomar alguna medida para mejorar su entorno o si queda en manos de los gobiernos locales implantar medidas que eviten la existencia de contaminación en los entornos cercanos a viviendas, programas de control de plagas y/o programas contra la delincuencia, entre otros.

Tabla 10: Índice de recuento bruto (no censurada) para la dimensión de refugio y medio ambiente

Dimensión refugio y medio ambiente	
Indicadores	Porcentaje de privación
Entorno físico en la cercanía del hogar	89,3%
Cercanía de servicios	41,9%
Hacinamiento	19,3%
Propiedad de la vivienda	3,8%
Agua potable	2,2%
Saneamiento	1,2%
Materialidad de la vivienda	1,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ELPI.

En la dimensión de amor y cuidado (ver tabla 11) el indicador conflictivo es el de cuidado, si se analiza las variables que lo componen se observa que un 67,2% de niños que se transportaron en un auto no utilizaron medidas de seguridad como ser: cinturón de seguridad, sillita de seguridad o alzador de seguridad. Por otra parte, un 18,15% de niños fueron expuestos al humo del cigarrillo lo que los convierte en fumadores pasivos, con todas las consecuencias que conlleva el tabaquismo. Para solucionar o disminuir estos niveles de privación se debe trabajar en la educación y concientización de los padres con respecto a los peligros que esto conlleva.

Tabla 11: Índice de recuento bruto (no censurada) para la dimensión de amor y cuidado

Dimensión amor y cuidado	
Indicadores	Porcentaje de privación
Cuidado	73,7%
Amor	21,3%
Estimulación temprana	14,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ELPI.

Si observamos detenidamente la dimensión de vida y salud física (ver tabla 12) es posible observar que los dos indicadores que presentan mayor porcentaje de niños privados son el de alimentación y nutrición junto al indicador de medidas antropométricas, estos indicadores si bien no son lo mismo ambos se encuentran altamente relacionados.

Por el lado de alimentación y nutrición una de las variables que incide en el alza abrupta del número de niños privados es el diagnóstico de exceso de peso que indica que un 31,2% de los niños fueron alguna vez diagnosticados con sobrepeso u obesidad, lo cual es relevante dada la corta edad de los niños. Con respecto al indicador de medidas antropométricas, específicamente el Índice de Masa Corporal (IMC) un 30% de los niños se encontraban con bajo peso (2,9%) o sobrepeso (28,04%). Esto es una medida de alerta dado que envía señales de que existen patrones de alimentación no sanos que empiezan desde una edad muy temprana y de mantenerse puede llevar a situaciones irreversibles que afectarán en los demás ciclos de la vida.

Tabla 12: Índice de recuento bruto (no censurada) para la vida y salud

Dimensión vida y salud	
Indicador	Porcentaje de privación
Alimentación y nutrición	44,2%
Medidas antropométricas	33,9%
Acceso a salud	12,9%
Presencia de enfermedades	11,9%
Vacunación e inmunización	1,2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ELPI.

Tomando en cuenta las dimensiones compartidas entre este estudio y el de Denis et al. (2010), las dimensiones de mayor privación en ambos estudios siguen el orden de: refugio y medio ambiente (vivienda), seguido de salud y educación, es decir, los resultados son consistentes al menos desde un punto de ranking.

6. CONCLUSIONES

La primera infancia es una etapa fundamental en la vida del niño dado que es en esta etapa donde se da gran parte de su desarrollo neurofisiológico, cognitivo y socioemocional, entre otros, dando paso a la formación de capacidades que lo acompañarán durante toda su vida.

Las particularidades de esta etapa llevan a considerar que una situación de carencias o privaciones tendrá efecto no solo en el desarrollo del niño, sino que influirán en el desarrollo de funcionamientos afectando su vida futura. Es por eso que surge la necesidad de generar metodologías que permitan conocer de forma más cercana las áreas en las que el niño se encuentre privado, para incidir en las mismas por medio de acciones, planes y programas que eviten situaciones de carencia y por tanto permitan su desarrollo.

El aporte de este estudio es que plantea un listado de capacidades que son esenciales para la primera infancia y a su vez sirven de dimensiones para la estimación de pobreza multidimensional en la primera infancia, el planteamiento de este listado sigue una exhaustiva justificación metodológica de por qué son dimensiones adecuadas para ser medidas en el contexto de la infancia e incorporan al niño como centro de la medición. Este listado de capacidades se relaciona además con los Derechos del Niño dando un marco normativo que debiera asegurar su cumplimiento a cabalidad. La conexión que se establece entre capacidades y derechos relaciona la necesidad del desarrollo de una capacidad con el ejercicio de un derecho.

A la fecha existen relativamente pocas investigaciones de pobreza en la infancia que siguen el enfoque de derechos y estos por el hecho de medir pocas dimensiones no incorporan la totalidad de los mismos, por lo que podrían considerarse como mediciones parciales o incompletas. Por otro lado, a la fecha, existe solo una medición de pobreza infantil que utiliza en enfoque de capacidades, en ese sentido la metodología que se propone además de abrir nuevos caminos de investigación cubre vacíos de otras mediciones.

El potencial de la metodología es que hace un planteamiento ideal lo suficientemente flexible para que pueda ser aplicado acorde a las realidades de cada país y en base a la disponibilidad de datos que se tengan.

Una consideración importante es que bajo el enfoque de derechos y capacidades no es posible establecer una línea de pobreza, porque el hacerlo implicaría jerarquizar las capacidades y daría paso a que un derecho pueda tener mayor valor que otro.

De la aplicación al caso chileno se extraen algunas conclusiones interesantes a saber. La primera de ellas es que el porcentaje de niños varones en situación de pobreza es mayor que el porcentaje de niñas en situación de pobreza bajo las mismas variables en estudio. Se encuentra además que la desnutrición por

exceso (sobrepeso y obesidad) se presenta incluso desde la primera infancia. Por otra parte, se debelen situaciones en donde existe falta de cuidado por parte de los padres poniendo en peligro su seguridad de los niños, sumado a que un gran porcentaje de hogares han experimentado en su entorno situaciones de contaminación, plagas, personas consumiendo o traficando drogas, balaceras, asaltos y/o robos.

Un aprendizaje importante que deja el estudio es que a pesar de utilizar un grupo relativamente similar en cuanto a edad y por ende indicadores más específicos para ese grupo etareo, la infancia, o al menos la primera infancia no deja de ser heterogénea, por lo que en ocasiones es necesario plantear umbrales de privación específicos acordes a la edad.

Algo relevante para la aplicación de esta metodología es la necesidad de una base de datos rica en variables tanto a nivel del niño como a nivel hogar. Es en ese sentido, se sugiere además que para futuras rondas de la Encuesta Longitudinal de la Primera Infancia (ELPI) se mantengan a lo largo del tiempo las mismas variables y evaluaciones para poder hacer un seguimiento longitudinal de la evolución de la pobreza en la primera infancia.

Finalmente, para futuras investigaciones sería interesante aplicar la metodología propuesta a grupos de niños de mayor edad e investigar cuáles son los factores que influyen en la existencia de un mayor porcentaje de niños privados en relación a niñas privadas en la primera infancia.

7. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- Adetola, A. y Olufemi, P. (2012). "Determinants of Child Poverty in Rural Nigeria: A Multidimensional Approach". *Global Journal of Human-Social Science Research*, 12(12-A).
- Alkire, S., Dorji, L., Gyeltshen, S., Minten, T. (2016). "*Child Poverty In Bhutan: Insights from Multidimensional Child Poverty Index (C-MPI) and Qualitative Interviews with Poor Children*". Buthan: National Statistics Bureau.
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). "Counting and multidimensional poverty measurement". *Journal of Public Economics*, 95(7-8), 476-487.
- Alkire, S. (2002). "*Dimensions of Human Development*". *World Development*, 30(2), 182-205.
- Amarante, V., R.Arim y A. Vigorito (2008). *Multidimensional poverty among children in Uruguay 2004-2006*. Evidence from panel data. In Meeting of the LACEA/IADB/WB/UNDP Network on Inequality and Poverty, Universidad Católica de Santo Domingo. Santo Domingo, República Dominicana.
- Almond, D., and Currie J. (2011). "*Human Capital Development Before Age Five.*" In *Handbook of Labor Economics*. Vol. 4B, edited by Orley Ashenfelter and David Card, 1315–1486. Amsterdam: Elsevier, North-Holland.
- Banco Mundial (2000). "*Poverty and Inequality Analysis*" en "*The World Bank: Poverty Reduction & Equity (2011)*". Disponible en www.go.worldbank.org , Febrero de 2019.
- Berger, K. S. (2007). "*Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia*". Ed. Médica Panamericana.
- Biggeri, M., Trani, J.F., and Mauro, V. (2010). "*The Multidimensionality of Child Poverty: an Empirical Investigation on Children of Afghanistan.*" Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI).
- Biggeri, M., Liberona, R., Mariana, S., Menchini, L. (2006) "Children conceptualizing their capabilities: results of a survey conducted during the first childrens world congress on child labour". *Journal of Human Development and Capabilities*, Vol. 7, No 1, Marzo 2006.
- Boltvinik, J., y Hernández, E. "*Conceptos y medidas de pobreza*". Pobreza y distribución del ingreso en México. Editorial Siglo XXI, México(1999).
- Bonfiglio, J. y Salvia A. (2015). "*Estimación de la pobreza multidimensional desde la perspectiva matricial bienestar/derechos 2010-2014*". Buenos Aires, Observatorio de la Deuda Social Argentina.
- Bourguignon, Francois, and Satya R. Chakravarty. "The measurement of multidimensional poverty". *The Journal of Economic Inequality* 1.1 (2003): 25-49.
- Bruno, S. y Osorio, A. (2015). "*La pobreza infantil multidimensional en Paraguay*". Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 2015.

- Camfield L. (2006). *"Why and How of Understanding "Subjective" Well-being: Exploratory work by the WeD group in four developing countries"*. WeD Working Paper 26.
- Campbell, S.B., Breaux, A.M., Ewing, L.J., & Szumowski, E.K. (1986). "Correlates and predictors of hyperactivity and aggression: A longitudinal study of parent-referred problem preschoolers". *Journal of Abnormal Child Psychology*, 14(2), 217–234.
- Cassiem, S., Perry, H., Sadan, M., Streak, J. (2000). *"Child poverty and the budget 2000: Are poor children put first?"* Institute for Democracy in South Africa (IDASA), Cape Town.
- Chakravarty y D'Ambrosio (2006). *"The measurement of social exclusion"*. Review of Income and Wealth Vol. 52, Issue 3, Publicado online en 2006.
- Childhood Poverty Research and Policy Centre (CHIP, 2004), *"Children and poverty: some questions answered"*. Disponible en:
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08d1de5274a27b200163f/CHIP_QA.pdf
Marzo, 2019.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2018). *"Medición de la pobreza por ingresos: actualización metodológica y resultados"*, Metodologías de la CEPAL, N° 2. (LC/PUB.2018/22-P), Santiago, 2018.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2013). *"Panorama Social de América Latina 2013"*. Santiago de Chile: CEPAL. Disponible en:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35904/1/S2013868_es.pdf
- CEPAL/UNICEF (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) (2010). *"Pobreza infantil en América Latina y el Caribe"*. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Publicación de las Naciones Unidas, diciembre. Disponible en:
https://www.unicef.org/honduras/Pobreza_infantil_America_Latina_Caribe_2010.pdf .
- Colacce, M. y Tennenbaum, V. (2016). *"Pobreza y privaciones múltiples en la infancia en Uruguay"*. CEPAL/UNICEF Uruguay.
- Consejo Nacional de la Infancia (2018). *"Informe: Situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile 2017"*, Gobierno de Chile, Santiago de Chile.
- Cunha, F., Heckman, J. J., Lochner, L., & Masterov, D. V. (2006). *"Interpreting the evidence on life cycle skill formation"*. *Handbook of the Economics of Education*, 1, 697-812.
- De Neubourg, C., et al. (2012). *"Cross-Country MODA Study: Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA)"*. Technical Note. No. Working Paper WP-2012-05, Florence, UNICEF Office of Research.
- Cusminsky, M., Lejarraga, H., Mercer, R., Martell, M., y Fescina, R. (1993). *"Manual de crecimiento y desarrollo del niño"*. Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Washington, D.C. 1993.

- Denis A., Gallegos F., Sanhueza C. *“Medición de Pobreza Multidimensional en Chile”*. Universidad Alberto Hurtado, Chile.
- De Milliano, M y Plavgo, I. (2014). *“Analysing Child Poverty and Deprivation in Sub-Saharan Africa”*. Office of Research Working Paper WP-2014-19.
- De Milliano, M. y Sudhanshu, H. (2014). *“Child Poverty and Deprivation in Mali. The first national estimates”*. Innocenti Working Paper, No. 2014-20, Florence, UNICEF Office of Research
- Di Tommaso, M.L. (2003). *“How to measure children’s well-being using a capability approach? An application to Indian data through a multiple indicators multiple causes model”*. Unpublished paper presented at the 3rd Conference on the Capability Approach: from Sustainable Development to Sustainable Freedom, University of Pavia, 7–9 September.
- Espíndola, E.Sunkel, G., Murden, A., Milosavlevic, V. (2018). *“Medición multidimensional de la pobreza infantil: Una revisión de sus principales componente teóricos, metodológicos y estadísticos”*. CEPAL, UNICEF. Naciones Unidas, Santiago.
- Gobierno de Chile, 2017. *“Sistema de Garantías de los Derechos de la niñez”*, Disponibles es: <https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmlD=109010&prmlTIPO=DOCUMENTOCOMISION> , Febrero 2019.
- Heckman, J., Pinto, R., & Savelyev, P. (2013). *“Understanding the Mechanisms Through Which an Influential Early Childhood Program Boosted Adult Outcomes”*. American Economic Review, 103(6), 2052–2086.
- Heckman, James J. 2008. *“Schools, Skills, and Synapses.”* Economic Inquiry 46 (3): 289–324.
- ICEFI/UNICEF (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales /Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) (2016). *“Pobreza multidimensional infantil y adolescente en Guatemala: privaciones a superar”*. Guatemala: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
- Iceta, A. y Yoldi M. E., (2002). *“Desarrollo psicomotor del niño y su valoración en atención primaria”*. Revista Anales de Sistema Sanitaria de Navarra, 2002. Pp. 35.
- Knudsen, Eric I., James J. Heckman, Judy L. Cameron, and Jack P. Shonkoff. 2006. *“Economic, Neurobiological and Behavioral Perspectives on Building America’s Future Workforce.”* Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (27): 10155–62
- Landiyanto, E.A. (2013). *“Multidimensional Child Poverty in Papua: Empirical Evidence from 6 Districts”*. Child Poverty and Social Protection Conference.
- Larraín, F. (2008). *“Cuatro millones de pobres en Chile: actualizando la línea de la pobreza”*. Estudios públicos, 109.
- Minujin, A. y Delamonica, D. (2012). *“Multidimensional child poverty in Tanzania: analysis of situation, changes and sensitivity of thresholds”*. *Global Child Poverty and Well-Being*, pp. 263.
- Minujin, A., Delamonica, E., Davidziuk, A., & Gonzalez, E. D. (2006). *“The definition of child poverty: a discussion of concepts and measurements.”* *Environment and Urbanization* 18.2 (2006): 481-500.

- Mohanty, S. K. (2011). "Multidimensional poverty and child survival in India". PLoS One, 6(10), e26857.
- Narbona, J., Crespo-Eguílaz, N. (2012). "Plasticidad cerebral para el lenguaje del niño y adolescente". Revista de Neurología, 2012.
- Notten, G., Neubourg, C., Makosso B., and Mpoue A.B.(2012). "A multidimensional profile of child poverty in Congo Brazzaville". *Global child poverty and well-being*, pp. 287
- Nussbaum, M. (2000). "Women and human development capability approach". Cambridge.
- OMS (Organización Mundial de la Salud) (2013) "Plan de Acción Mundial sobre Vacunas: 2011 – 2020", p. 110-131.
- ONU (Organización de Naciones Unidas): Asamblea General (1989) "Convención sobre los Derechos del Niño", United Nations, Treaty Series, vol. 1577, p. 3.
- OPS (Organización Panamericana de la Salud) (2003). Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. 10a. revisión. Washington, D.C. : OPS, 1995.
- PNUD (Programa Naciones Unidas para el Desarrollo) (1997). "Informe Sobre Desarrollo Humano 1997". Disponible en: http://desarrollohumano.cl/idh/download/hdr_1997_en_complete_nostats.pdf, Febrero, 2019.
- Qi, D. y Wu, Y. (2014). "Child poverty in China-a multidimensional deprivation approach". Child Indicators Research, 7(1), 89-118.
- Robeyns, I. (2005). "Selecting capabilities for quality of life measurement". Social indicators research (2005), 74: 191-215.
- Robeyns, I. (2003) "The capability Approach: An Interdisciplinary Introduction". University of Amsterdam, Amsterdam. Pp. 63.
- Roche, J.M. (2013). *Monitoring progress in child poverty reduction: methodological insights and illustration to the case study of Bangladesh*. Social indicators research, 112(2), 363-390.
- Sen, A. (2004). "Capabilities, list, and public reason". *Feminist Economics* 10(3), 77-80.
- Sen, A. (1987). "The standard of living", in G. Hawthorn (Ed.), *The Standard of Living*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Sen, A. (1976). "Poverty: an ordinal approach to measurement". *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 219-231.
- Spicker, P. (1999). "Definiciones de pobreza: Doce grupos de significados". P Spicker, S Alvarez Leguizamon, D Gordon, *Pobreza: un glosario internacional*, Colección CLACSO-CROP, pp 291-306.
- Spitz, R.A., & Wolf, K.M (1949). Anaclitic Depression. *The Psychoanalytic Study of the Child*, 2(1), 313- 342.
- STPP/UNICEF (Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de El Salvador/Fondo de las Naciones Unidas para la infancia) (2015). "Percepciones de niñas, niños y adolescentes sobre

su bienestar: ¿Apostando por el futuro de El Salvador?”. Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) El Salvador.

- Straus, M. A. (1997). “*Spanking by Parents and Subsequent Antisocial Behavior of Children*”. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 151(8), 761.
- Torres, L. (2014). “*Pobreza multidimensional de la infancia en Colombia*”. Tesis doctoral, Universidad de La Sabana.
- Trani, J.F. y Cannings T.I. (2013). “*Child poverty in an emergency and conflict context: A multidimensional profile and an identification of the poorest children in Western Darfur*”. *World Development*, 48, 48-70.
- Tuñón, I. y González, M. (2013). “*Aproximación a la medición de la pobreza infantil desde un enfoque multidimensional y de derechos*”. *Revista Sociedad y Equidad*, (5).
- UNICEF (2017). “Niños, niñas y adolescentes en Chile: 2018”. Disponible en: <http://unicef.cl/web/cifras-unicef/>, Marzo, 2019.
- UNICEF (2016). “*Los múltiples rostros de la pobreza infantil en Honduras: un desafío prioritario*”. Tegucigalpa: UNICEF.
- UNICEF (2010). “*Pobreza infantil en América Latina y el Caribe*”. UNICEF, New York
- UNICEF (2004). “*Estado Mundial de la Infancia 2005: La infancia amenazada*”. UNICEF, New York.
- UNICEF (2001). “*Estado Mundial de la Infancia 2001*”. UNICEF, New York.
- UNICEF (2000). “*Maltrato infantil en Chile: UNICEF responde*” Unicef: Oficina de área para Argentina, Chile y Uruguay. Santiago, Chile.
- UNICEF/Informal Settlements Development Facility, Egypt (2013). “*Multidimensional Child poverty in slums and unplanned areas in Egypt*”. Cairo, UNICEF Egypt y ISDF.
- Universidad de Los Andes/UNICEF (2012). “*Análisis de Situación de la Pobreza Infantil en Colombia y Revisión del Sistema de Protección Social sensible a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes en Colombia*”. Bogotá: Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, Universidad de los Andes.
- Volpe, J. (2008). *Neurology of the newborn*, 5th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier.
- White, S. (2002). “Being, becoming and relationship: conceptual challenges of a child rights approach in developmen”. *Journal of International Development*, 14(8), pp. 1095-1104.

8. ANEXOS

Anexo A: Metodología CONEVAL

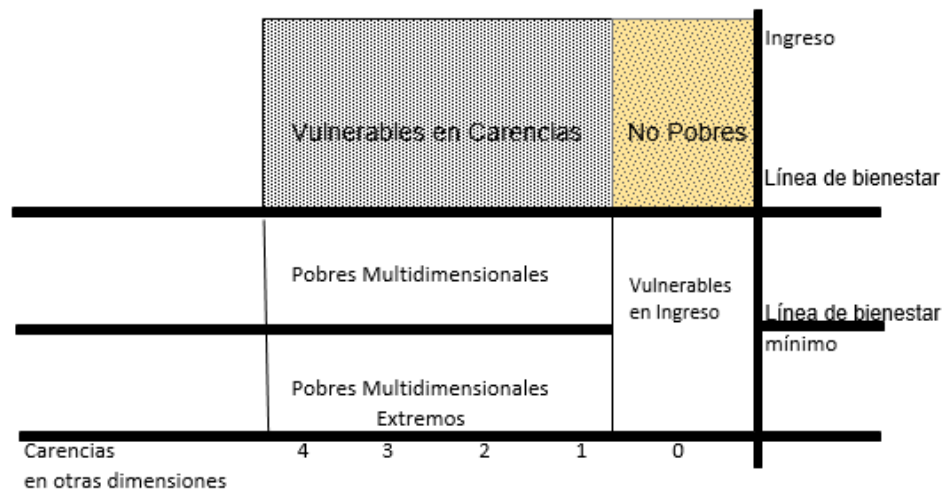
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México (CONEVAL) es una organización gubernamental mexicana cuyas funciones son: (i) normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecutan las dependencias públicas; y (ii) establecer los lineamientos y criterios para la definición y medición de la pobreza.

Este organismo dio a conocer su nueva metodología de medición de pobreza multidimensional el 10 de diciembre de 2009. La metodología CONEVAL incorpora un grupo de dimensiones asociadas a los derechos sociales, es decir, la educación, la salud, la seguridad social, la alimentación, la vivienda y sus servicios; los cuales se miden por medio de seis indicadores de carencia social. Bajo esta metodología se identifica que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.

La metodología divide a la población en cinco grupos:

- **Pobres multidimensionales:** población con ingreso inferior al valor de la línea de bienestar y que padece al menos una carencia social (cuadrante I).
- **Vulnerables por carencias sociales:** población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar (cuadrante II).
- **Vulnerables por ingresos:** población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar (cuadrante III).
- **No pobres multidimensionalmente y no vulnerables:** población cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar y que no tiene carencia social alguna (cuadrante IV).
- **Pobreza multidimensional extrema:** personas que se encuentran bajo la línea de indigencia en la dimensión de ingresos y presentan 3 o más carencias en otras dimensiones, en edad económicamente activa, o que presenta 2 o más carencias en otras dimensiones para menores de 15 años o adultos mayores.

En la figura a continuación se muestra una representación de cada uno de los grupos que considera esta metodología.



Fuente: Medición de Pobreza Multidimensional en Chile, Denis et al., 2010, p.88.

Anexo B: Decálogo de capacidades centrales para el funcionamiento humano de Martha Nussbaum.

- *Integridad corporal.*
- *Alfabetización y educación científica básica.*
- **Vida:** Ser capaz de vivir hasta el final una vida humana de extensión normal; no morir prematuramente, o antes de que la propia vida se haya reducido de tal modo que ya no merezca vivirse.
- **Salud corporal:** Ser capaz de tener buena salud, incluyendo la salud reproductiva; estar adecuadamente alimentado; tener un techo adecuado.
- **Integridad corporal:** Ser capaz de moverse libremente de un lugar a otro; que los límites del propio cuerpo sean tratados como soberanos, es decir, capaces de seguridad ante asalto, incluido el asalto sexual, el abuso sexual de menores y la violencia doméstica; tener oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección de materia de reproducción.
- **Sentidos, imaginación y pensamiento:** Ser capaz de utilizar los sentidos, de imaginar, pensar y razonar, y de hacer todo esto de forma “verdaderamente humana”, formas plasmada y cultivada por una adecuada educación, incluyendo, aunque no solamente, alfabetización y entrenamiento científico y matemático básico. Ser capaz de utilizar la imaginación y el pensamiento en conexión con la experiencia y la producción de obras y eventos de expresión y elección propia, en lo religioso, literario, musical, etc. Ser capaz de utilizar la propia mente de manera protegida por las garantías de libertad de expresión con respecto tanto al discurso político como artístico, y libertad de práctica religiosa. Ser capaz de buscar el sentido último de la vida a la propia manera. Ser capaz de tener experiencias placenteras y de evitar el sufrimiento innecesario.
- **Emociones:** Ser capaz de tener vinculaciones con cosas y personas fuera de uno mismo, de amar a quienes nos aman y cuidan de nosotros, de penar por su ausencia, y, en general, de amar, de pensar, de experimentar nostalgia, gratitud y temor justificado. Que el propio desarrollo emocional no esté arruinado por un temor o preocupación aplastante, o por sucesos traumáticos de abuso o descuido. Apoyar esta capacidad significa apoyar formas de asociación humana que pueden mostrarse como cruciales.
- **Razones prácticas:** Ser capaz de plasmar una concepción del bien y de comprometerse en una reflexión crítica acerca del planeamiento de la propia vida. Esto implica protección de la libertad de conciencia.
- **Afiliación:**
 - o Ser capaz de vivir con y hacia otros, de reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos, de comprometerse en diferentes maneras de interacción social; ser capaz de imaginarse la situación de otros y de tener compasión de tal situación; ser capaz tanto de justicia cuanto de amistad. Proteger esta capacidad significa proteger instituciones que

constituyen y alimentan tales formas de afiliación, y proteger asimismo la libertad de reunión y de discurso político.

- Poseer las bases sociales del respeto de sí mismo y de la no-humillación; ser capaz de ser tratado como un ser dignificado cuyo valor es igual al de los demás. Esto implica, como mínimo, protección contra la discriminación basada en la raza, el sexo, la orientación sexual, la religión, la casta, la etnia. o el origen nacional. En el trabajo, ser capaz de trabajar como un ser humano, haciendo uso de la razón práctica e ingresando en significativas relaciones de reconocimiento mutuo con otros trabajadores.
- **Otras especies:** Ser capaz de vivir con cuidado por los animales, las plantas y el mundo de la naturaleza y en relación con todo ello.
- **Juego:** Ser capaz de reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.
- **Control del propio entorno:**
 - **Político:** Ser capaz de participar efectivamente en elecciones políticas que gobiernen la propia vida; tener el derecho de participación política, de protecciones de la libre expresión y asociación.
 - **Material:** Ser capaz de tener propiedad (tanto de la tierra como de bienes muebles), no solamente de manera formal sino en términos de real oportunidad; y tener derechos de propiedad sobre una base de igualdad con otros; tener el derecho de buscar empleo sobre una base de igualdad con otro; no estar sujeto a registro e incautación de forma injustificada.

Fuente: Nussbaum, 2000. Capítulo capacidades centrales.

Anexo C: Objetivos epistemológicos, metodologías y rol de los funcionamientos y capacidades

Objetivo epistemológico	Metodología	Rol de los funcionamientos y capacidades
Bienestar/Calidad de la medición	Cuantitativa Empírica	Indicadores sociales
Descripción gruesa/ Análisis descriptivo	Cualitativa Empírica	Elementos de narrativa
Teorías normativas	Filosófica	Parte de bases filosóficas

Fuente: Robeyns, 2005.

Anexo D: Derechos e institucionalidad en relación a la infancia en Chile

Marco Legal

Chile en 1967 promulgó la Ley de Menores N° 16.618, la que se aplica a todos los menores de edad y aborda temas en relación con la policía, los juzgados de Letras de Menores, las Casas de Menores e Instituciones Asistenciales y sus correspondientes disposiciones legales. A lo largo de todos los artículos que componen dicha ley es posible apreciar que el Estado considera a los Menores de Edad, como *objetos de derecho*, y no como sujetos de derecho, lo que podría ser interpretado como paternalista y asistencial.

En 1990 Chile ratificó la Convención de Derechos del Niño (según el Decreto 830), este tratado internacional reconoce a los niños como *sujetos de derecho* e incorpora como principio fundamental el interés superior del niño. De esta manera se introduce una nueva actitud hacia los niños, estos ya no son vistos como simples receptores de servicios y beneficiarios de medidas de protección, sino como sujetos de derechos y participantes en las acciones que los afecten.

En el año 2009, por primera vez en el país se concretó un esfuerzo formal para monitorear los derechos de los niños, niñas y adolescentes con la sistematización de información oficial plasmada en el “Primer Informe de Infancia y Adolescencia en Chile”, este documento se llevó a cabo en el marco de la puesta en marcha del programa “Chile Crece Contigo”.

De acuerdo al Derecho Internacional Público, los tratados internacionales de Derechos Humanos⁶⁷ son normas *Ius Cogens*⁶⁸, por lo que estos derechos adquieren un rango constitucional en el momento en que un país los ratifique y por tanto deberían estar asegurados en su totalidad. Aún así, si no se tomase en cuenta lo que dicta el Derecho Internacional Público (que todos los Derechos del Niño deberían encontrarse cubiertos en su totalidad dada la ratificación de la CDN por parte de Chile), al menos por la vía del Derecho Nacional Público cabría esperar que aquellas dimensiones -para la medición de pobreza infantil que se proponen en este estudio- que estén relacionadas con los Derechos Constitucionales⁶⁹ tengan una cobertura completa o al menos experimenten un menor nivel de privaciones dado que se encuentran asegurados por la Constitución.

En la tabla “Relación de capacidades y Derechos Constitucionales chilenos” se presenta la relación que existe entre las dimensiones de pobreza infantil y los artículos de la Constitución Política de la República de Chile (CPR) que aseguran dichas dimensiones. Como se puede observar no todas las capacidades y

⁶⁷ En estos se incluye los derechos de los niños asegurados en la Convención de Derechos del Niño.

⁶⁸ Término empleado en el Derecho Internacional Público para hacer referencia a aquellas normas de Derecho Imperativo que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido.

⁶⁹ Contenidos en el Art. 19 de la Constitución Política de la República Chile.

Derechos del Niño están asegurados por la CPR, en ese sentido, ya es posible apreciar una brecha en el grado de cumplimiento de los Derechos del Niño.

Obviando todo lo anterior, se debería esperar que haya un menor nivel de privación en las dimensiones de: vida y salud física, integridad y seguridad, relaciones sociales, participación e información, educación, refugio y medio ambiente y respeto; dado que estas tienen relación directa con algún Derecho Constitucional.

Tabla: Relación de capacidades y Derechos Constitucionales chilenos.

N°	Capacidad	Numerales del Artículo 19 de la CPR	
		Relación Directa	Relación Indirecta
1	Vida y salud física	1, 9, 18	-
2	Amor y cuidado	-	-
3	Bienestar mental	-	1, 18
4	Integridad y seguridad	7(b)	2, 7(c), 7(d)
5	Relaciones sociales	13	4, 18
6	Participación e información	12, 13, 15	14
7	Educación	10, 18	11
8	Protección contra la explotación económica y no económica	-	21
9	Refugio y medio ambiente	8, 18	5, 7(g), 24
10	Actividades de ocio y juego	-	-
11	Respeto	4, 22	-
12	Identidad	-	-
13	Tiempo autónomo	-	25
14	Movilidad	-	7(a),

Fuente: Elaboración propia en la Constitución Política de la República de Chile.

Institucionalidad

Con respecto a las instituciones chilenas, durante la segunda década del siglo XXI el gobierno creó y puso en vigencia entidades y mecanismos encargados de velar por el bienestar de los niños; en 2014 se fundó el Consejo Nacional de la Infancia (CNI), en 2015 se creó el Observatorio Nacional de los Derechos de la Niñez cuyo propósito es la consolidación y desarrollo de información confiable para el análisis crítico y comprensivo del estado de la situación de los derechos de los NNA.

Por otra parte, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (CRC) supervisa la aplicación de la CDN y examina los informes de cada país⁷⁰, expresando sus preocupaciones y recomendaciones a cada Estado parte.⁷¹ En ese contexto, durante el año 2015 el CRC en sus recomendaciones para Chile expresa su preocupación y observa “la falta de indicadores para supervisar y evaluar el respeto de los derechos del niño”.

En respuesta a esta preocupación, el CNI en el 2016 generó un levantamiento de Línea Base de la situación de los derechos de los NNA en Chile y creó el portal Creciendo con Derechos⁷², en donde se publican los avances en materia de derechos para la infancia junto con los indicadores vinculados a los compromisos del Estado en esta materia. En este marco, en 2017 se presentó y puso en vigencia el Sistema Estadístico sobre la Niñez y Adolescencia (SIENA), una plataforma que pretende integrar diferentes bases de datos para presentar información estadística aportando al monitoreo de la situación de Derechos de NNA en Chile. Finalmente, en 2018 se aprobó la creación de un Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez y la creación de la Subsecretaría de la Niñez, la que reemplaza al CNI.

⁷⁰ Los Estados parte de la Convención de Derechos del Niño tienen la responsabilidad de presentar periódicamente ante el comité informes que den cuenta del grado de avance en el ejercicio de los derechos por para de los niños en su territorio.

⁷¹ Los Estados que supervisa el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas son todos aquellos que hayan ratificado la Convención de Derechos del Niño.

⁷² www.creciendoconderechos.gob.cl

Anexo E: Definición de indicadores y umbrales de privación severa y moderada entre los niños

Niveles de privación	Moderada (incluye el umbral de privación severa)	Severa/Grave	Unidad de análisis en la que se mide y a la que se aplica el indicador	Artículo violado de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
Dimensiones e indicadores de privación				
Nutrición* - Relación peso/edad - Relación talla/edad	Insuficiencia ponderal moderada -grave (desnutrición global) o baja talla para la edad moderada grave (desnutrición crónica) menos de -2 desviaciones estándar respecto el patrón de referencia	Insuficiencia ponderal grave o baja. Talla grave: menos de -3 desviaciones estándar respecto del patrón de referencia	Niños de 0 a 4 años	24 (2) (c) Salud
Agua potable Acceso al agua potable según: - Origen - Suministro - Tiempo de acceso (si está disponible)	- Origen del agua por pozo o noria - Suministro de agua fuera de la vivienda y fuera del predio (pilones públicos, camiones aljibe y otros)	Origen inseguro del agua: fuentes naturales de agua (ríos, vertientes) En el caso de la disponibilidad de algún indicador de acceso a la fuente de agua, 15 minutos o más	Vivienda Niños y adolescentes de 0 a 17 años	24 (2) (c) Salud
Saneamiento Conexión a sistema de alcantarillado (eliminación de excretas)	Sin conexión a alcantarillado (por ejemplo, pozos negros) o acceso fuera de la vivienda o predio	Sin servicio de eliminación de excretas (por ejemplo: directo al río)	Vivienda Niños y adolescentes de 0 a 17 años	24 (2) (c) Salud
Vivienda - Razón de personas por dormitorio o pieza - Material del piso, de los muros y del techo	Hacinamiento: tres o más personas por dormitorio – o pieza- (excluye baño y cocina). Viviendas con piso de tierra, materiales de construcción inseguros (muros y techos de barro o materiales similares)	Hacinamiento: cinco o más personas por dormitorio – o pieza- Viviendas transitorias (carpas y similares) muros o techos fabricados con materiales de desecho	Vivienda Niños y adolescentes de 0 a 17 años	27 (3) Estándar de vida

(Continuación)

Niveles de privación	Moderada (incluye el umbral de privación severa)	Severa/Grave	Unidad de análisis en la que se mide y a la que se aplica el indicador	Artículo violado de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
Dimensiones e indicadores de privación				
Educación Asistencia escolar y número de años de estudios y completados	Niños y adolescentes que, habiendo asistido a la escuela, hicieron abandono de ella antes de completar la enseñanza secundaria	Niños y adolescentes que no han asistido nunca a la escuela	Niños desde 7 u 8 años hasta 17 años	28 (1) (a) y (b) Educación
Información Acceso a electricidad, tenencia de radio, televisión o teléfono	Sin acceso en la vivienda a electricidad, a teléfono (fijo o móvil), a radio y televisión (al menos dos componentes disponibles)	Sin acceso en la vivienda a electricidad, teléfono, fijo o móvil), radio y televisión, (simultáneamente)	Hogar Niños y adolescentes de 0 a 17 años	13/17 Información

Fuente: UNICEF, 2010, p.28.

Anexo F: Umbrales de privación por variables (no censurado)

Dimensión	Indicadores	Variable	Peso	Umbral de privación	Porcentaje Privación	Observaciones
Vida y salud física	Vacunación e inmunización	Vacunas correspondientes para la edad	2,0%	Privado si el niño no tiene todas las vacunas que corresponden para su edad	1,2%	4086
	Acceso a servicios de salud	Sistema previsional de salud	0,7%	Privado si no posee sistema previsional de salud, es decir, utiliza servicios de salud como particular	2,0%	4089
		Control y número de controles durante el embarazo	0,7%	Privado si la madre no controló su embarazo o si lo controló, pero asistió a menos de 6 controles	6,8%	4074
		Número de consultas que tuvo el niño al doctor/pediatra o controles que tuvo al niño sano	0,7%	Privado si nunca fue a controles del niño sano o un control con un médico general o pediatra en los últimos 12 meses	5,6%	4114
	Alimentación y nutrición	Estado nutricional del niño	0,3%	Privado si es que está en desnutrición o riesgo de desnutrición, en sobrepeso u obeso	23,2%	4105
		Alguna vez fue diagnosticado por un profesional de la salud exceso de peso	0,3%	Privado si se encuentra en sobrepeso u obesidad	31,2%	4101
		El niño es o fue amamantado	0,3%	Privado si nunca fue amamantado	6,4%	4103

Dimensión	Indicadores	Variable	Peso	Umbral de privación	Porcentaje Privación	Observaciones
(continuación)		Consumo de proteínas	0,3%	Privado si es mayor de 2 años y come menos de una vez a la semana o no come pescado, marisco o legumbres		3926
		Consumo de frutas y verduras	0,3%	Privado si es mayor de dos años y nunca consumo frutas y verduras en una semana	0,5%	4020
		Consumo de lácteos	0,3%	Privado si es mayor de dos años y consume lácteos menos de una vez a la semana	1,3%	4020
	Medidas antropométricas	Peso para la edad	0,7%	Privado si la interpretación de la medida se clasifica como retraso	1,5%	4010
		Talla para la edad	0,7%	Privado si la interpretación de la medida se clasifica como retraso	6,7%	3998
		Índice de masa corporal	0,7%	Privado si se encuentra en bajo peso o sobrepeso	31,9%	3955
	Presencia de enfermedades y estado de salud	Presencia de enfermedades en los últimos 12 meses sin tratamiento según la clasificación de cáncer	0,3%	Privado si presenta la enfermedad y no ha recibido medicamento o tratamiento médico	0,3%	4108
		Presencia de enfermedades en los últimos 12 meses sin tratamiento	0,3%	Privado si presenta la enfermedad y no ha recibido medicamento	4,8%	4070

Dimensión	Indicadores	Variable	Peso	Umbral de privación	Porcentaje Privación	Observaciones
(continuación)		según la clasificación de crónicas		o tratamiento médico		
		Presencia de enfermedades en los últimos 12 meses sin tratamiento según la clasificación de desarrollo	0,3%	Privado si presenta la enfermedad y no ha recibido medicamento o tratamiento médico	5,7%	4083
		Presencia de enfermedades en los últimos 12 meses sin tratamiento según la clasificación de hereditarias	0,3%	Privado si presenta la enfermedad y no ha recibido medicamento o tratamiento médico	0,3%	4098
		Presencia de enfermedades en los últimos 12 meses sin tratamiento según la clasificación de malformaciones	0,3%	Privado si presenta la enfermedad y no ha recibido medicamento o tratamiento médico	0,8%	4099
		Presencia de enfermedades en los últimos 12 meses sin tratamiento según la clasificación de otras	0,3%	Privado si presenta la enfermedad y no ha recibido medicamento o tratamiento médico	1,7%	4090
		Presencia de enfermedades en los últimos 12 meses sin tratamiento según la clasificación de mentales	0,3%	Privado si presenta la enfermedad y no ha recibido medicamento o tratamiento médico	2,6%	4088
Amor y cuidado	Amor y atención	El cuidador le habla al niño/a, al menos dos veces durante la visita	0,8%	Privado si el cuidador no lo hace durante la visita	2,7%	4095
		El cuidador le da besos, caricias, o abrazos al niño/a, al menos una vez	0,8%	Privado si el cuidador no lo hace durante la visita	17,9%	4095

Dimensión	Indicadores	Variable	Peso	Umbral de privación	Porcentaje Privación	Observaciones
(continuación)		El cuidador contesta verbalmente a preguntas o peticiones del niño/a	0,8%	Privado si el cuidador no lo hace durante la visita	6,6%	4095
		El cuidador transmite al niño/a sentimientos positivos	0,8%	Privado si el cuidador no lo hace durante la visita	4,5%	4095
	Cuidado	El niño se quedó solo en casa o al cuidado de otro niño	1,1%	Privado si se quedó sólo en casa o al cuidado de otro niño algún día de la semana	0,9%	4114
		Exposición del niño al humo del cigarro	1,1%	Privado si está expuesto al humo del cigarro frecuente u ocasionalmente	16,5%	4114
		Uso de medidas de seguridad al ser transportado en auto	1,1%	Privado si se transportó y no siempre usó alguna medida de seguridad como cinturón de seguridad, sillita de seguridad o alzador de seguridad	67,3%	4114
	Estimulación temprana	El cuidador principal o secundario le canta al niño	0,5%	Privado si ninguno de sus cuidadores lo hace	4,9%	4114
		El cuidador principal o secundario le enseñan los animales y sus sonidos	0,5%	Privado si ninguno de sus cuidadores lo hace a partir de los dos años	4,3%	4114
		El cuidador principal o secundario le	0,5%	Privado si ninguno de sus	3,9%	4114

Dimensión	Indicadores	Variable	Peso	Umbral de privación	Porcentaje Privación	Observaciones
(continuación)		enseñan los colores		cuidadores lo hace a partir de los dos años		
		El cuidador principal o secundario le enseñan los números o a contar	0,5%	Privado si ninguno de sus cuidadores lo hace a partir de los dos años	2,7%	4114
		El cuidador principal o secundario le enseñan las letras	0,5%	Privado si ninguno de sus cuidadores lo hace a partir de los dos años	5,1%	4114
		El cuidador principal o secundario le leyó un libro, miró con él/ella los dibujos de un libro o le contaron cuentos	0,5%	Privado si ninguno de sus cuidadores lo hace a partir del año	5,4%	4114
		El cuidador principal o secundario le nombra, cuenta o dibuja cosas	0,5%	Privado si ninguno de sus cuidadores lo hace a partir de los dos años	3,0%	4114
Bienestar mental	Evaluaciones socioemocionales	Categoría diagnóstica de reactividad emocional según Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría	1,4%	Privado si se encuentra en riesgo o en rango clínico	8,5%	3920
		Categoría diagnóstica de ansiedad/depresión según Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos	1,4%	Privado si se encuentra en riesgo o en rango clínico	9,1%	3920

Dimensión	Indicadores	Variable	Peso	Umbral de privación	Porcentaje Privación	Observaciones
(continuación)		Mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría				
		Categoría diagnóstica de quejas somáticas según Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría	1,4%	Privado si se encuentra en riesgo o en rango clínico	15,9%	3919
		Categoría diagnóstica de ensimismamiento /autismo según Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría	1,4%	Privado si se encuentra en riesgo o en rango clínico	14,1%	3920
		Categoría diagnóstica de problemas del sueño según Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría	1,4%	Privado si se encuentra en riesgo o en rango clínico	3,1%	3920
		Categoría diagnóstica de problemas atencionales según Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría	1,4%	Privado si se encuentra en riesgo o en rango clínico	5,2%	3920

Dimensión	Indicadores	Variable	Peso	Umbral de privación	Porcentaje Privación	Observaciones
(continuación)		Categoría diagnóstica de conductas agresivas según Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría	1,4%	Privado si se encuentra en riesgo o en rango clínico	5,8%	3920
Relaciones sociales	Compañía embarazo	Madre es acompañada a los controles de embarazo	5,0%	Privado si nadie la acompañó	15,0%	4114
		Madre es acompañada durante el parto	5,0%	Privado si nadie acompañó a la madre durante el parto	9,1%	4095
Integridad y seguridad corporal	Violencia reportada	El niño recibió algún tipo de violencia física	1,7%	Privado si alguna vez recibió algún tipo de violencia física sobre los 5 años	7,4%	4021
		El niño recibió algún tipo de violencia psicológica	1,7%	Privado si alguna vez recibió algún tipo de violencia psicológica sobre los cinco años	17,8%	4021
		El niño ha presenciado peleas entre los integrantes del hogar	1,7%	Privado si presencié peleas o amenazas entre los integrantes del hogar sobre los cinco años	2,7%	4114
	Violencia observada	El encuestador observa que el cuidador le pega al niño durante la entrevista	2,5%	Privado si le pega al niño durante la visita	11,1%	4095

Dimensión	Indicadores	Variable	Peso	Umbral de privación	Porcentaje Privación	Observaciones
(continuación)		El encuestador observa que el cuidador expresa hostilidad hacia el niño	2,5%	Privado si su cuidador expresa hostilidad	12,4%	4095
Participación e información	Acceso a medios de información	Conocimiento del programa Chile Crece Contigo	5,0%	Privado si no conoce el programa	23,9%	4114
		En el hogar hay alguien que tenga computador, tablet o teléfono móvil conectado a internet	5,0%	Privado si en el hogar no hay nadie que tenga un computador, tablet o celular conectados a internet	23,1%	4101
Educación	Acceso a sistemas educativos	Existencia de establecimiento educacional cercano al hogar o trabajo por edad	2,5%	Privado si no existe un establecimiento educacional cercano al hogar o al trabajo del cuidado principal	13,1%	3771
		Asistencia a centro educacional sobre los dos años	2,5%	Privado si sobre los dos años no asiste a un centro educacional	21,3%	3802
	Educación de los padres	Nivel educacional de ambos padres	5,0%	Privado si ambos padres no alcanzaron 8 años de escolaridad	0,0%	4069
Refugio y medio ambiente	Materialidad vivienda	Está privado si vive en una mediagua, mejora o vivienda de emergencia, en un rancho o choza, o en una vivienda precaria de materiales reutilizados	1,4%	Privado si vive en una media agua, mejora o vivienda de emergencia, en un rancho o choza o en una vivienda precaria de materiales reutilizados	1,1%	4114

Dimensión	Indicadores	Variable	Peso	Umbral de privación	Porcentaje Privación	Observaciones
(continuación)	Saneamiento	Dispone de un adecuado sistema de eliminación de excretas	1,4%	Se encuentra privado si no tienen un sistema de eliminación de excretas adecuado (solución diferente a W.C. conectado a alcantarillado o fosa séptica)	1,2%	4114
	Agua potable	Lugar de procedencia del agua	1,4%	Privado si recibe agua de un pozo o noria, río, vertiente, lago o estero, camión aljibe u otra fuente	2,2%	4114
	Hacinamiento	Hacinamiento en el hogar	1,4%	Privado si en el hogar hay hacinamiento, ya sea medio bajo, medio alto o crítico	19,3%	4114
	Tenencia de propiedad/vivienda	Tenencia de vivienda	1,4%	Privado si la vivienda se encuentra bajo situación de usufructo (sólo uso y goce), bajo una ocupación irregular (de hecho) o es poseedor irregular	3,8%	4114

Dimensión	Indicadores	Variable	Peso	Umbral de privación	Porcentaje Privación	Observaciones
(continuación)	Cercanía servicios	Existencia de servicios en la cercanía de la vivienda	1,4%	Privado si en la cercanía de la vivienda no existía a menos de 8 cuadras o 1 km un servicio de transporte público, o menos de 20 cuadras o 2,5 km para el caso de una sala cuna o jardín infantil, una escuela o colegio, un centro de salud, un supermercado, almacén o feria, un equipamiento deportivo (centros deportivos, canchas, skate park, etc.), áreas verdes, equipamiento comunitario (centros vecinales, sedes sociales, biblioteca vecinal o centro cultural comunitario) o una farmacia.	41,9%	4052
	Entorno físico	Contaminación y/o malos olores en las cercanías del hogar en los últimos 12 meses	0,1%	Privado si experimentó pocas veces, muchas veces o siempre	46,8%	4114
		Contaminación en ríos, mar, canales, esteros, lagos, tranque y	0,1%	Privado si experimentó pocas veces, muchas	15,8%	4114

Dimensión	Indicadores	Variable	Peso	Umbral de privación	Porcentaje Privación	Observaciones
(continuación)		embalses en la cercanía del hogar		veces o siempre		
		Contaminación de agua proveniente de la red pública	0,1%	Privado si experimentó pocas veces, muchas veces o siempre	19,5%	4114
		Acumulación de basura en calles, caminos, veredas o espacios públicos	0,1%	Privado si experimentó pocas veces, muchas veces o siempre	45,7%	4114
		Plagas de insectos, animales peligrosos o abandonados (termitas, cucarachas, roedores, murciélagos, perros, etc.)	0,1%	Privado si experimentó pocas veces, muchas veces o siempre	43,1%	4114
		Personas consumiendo drogas o alcohol en la vía pública	0,1%	Privado si experimentó pocas veces, muchas veces o siempre	61,3%	4114
		Personas traficando drogas en la vía pública	0,1%	Privado si experimentó pocas veces, muchas veces o siempre	37,3%	4114
		Personas peleando o amenazándose en la vía pública	0,1%	Privado si experimentó pocas veces, muchas veces o siempre	43,4%	4114
		Balaceras o disparos de armas de fuego	0,1%	Privado si experimentó pocas veces, muchas veces o siempre	35,9%	4114
		Asaltos, robos a la propiedad, etc.	0,1%	Privado si experimentó	45,6%	4114

Dimensión	Indicadores	Variable	Peso	Umbral de privación	Porcentaje Privación	Observaciones
(continuación)				pocas veces, muchas veces o siempre		
Tiempo de ocio	Juego cuidadores	Juego con los cuidadores principales	5,0%	Privado si en los últimos 7 días ninguno de sus cuidadores principales jugó con el niño	1,2%	4035
	Actividades en el exterior	Los cuidadores principales del niño lo llevan a una plaza, parque, ludoteca o juego público en los últimos 7 días	2,5%	Privado si ninguno de sus cuidadores lo lleva	8,1%	4114
		Los cuidadores principales del niño lo llevan a un museo, zoológico, biblioteca u otro paseo cultural en los últimos 7 días	2,5%	Privado si ninguno de sus cuidadores lo lleva	37,0%	4114
Religión e identidad	Registro civil	Registro civil	5,0%	Privado si no cuenta con partida de nacimiento y/o no está registrado en el registro civil	0%	4114
		El niño/a da su nombre y apellidos	5,0%	Privado si el niño tiene más de dos años y no dice su nombre y apellido o ambos	16,8%	4114

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ELPI.

Anexo G: Clasificaciones de enfermedades de acuerdo a la clasificación internacional de la Organización Panamericana de la Salud

- **Cáncer**
- **Crónicas:** asma o enfermedad respiratoria crónica, enfermedades al corazón que no sean producto de malformaciones, enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión, dislipidemia (colesterol alto), bocio o enfermedad de la tiroides, epilepsia, migraña, enfermedad celíaca, alergias alimentarias y otros problemas de salud crónicos.
- **Desarrollo:** Autismo, síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo u otros trastornos del espectro del autismo, parálisis cerebral, Síndrome de Down u otra alteración genética, problemas de desarrollo psicomotor, dificultades de aprendizaje, problemas de habla u otros problemas del lenguaje, sordera o pérdida de audición y ceguera o pérdida de visión.
- **Hereditarias:** Síndrome alcohólico fetal
- **Malformaciones:** Pérdida, ausencia o malformaciones de brazos, piernas o dedos; y malformaciones congénitas cardíacas, labio leporino, espina bífida u otro.
- **Mentales:** Problemas de conducta o de comportamiento, como trastorno oposicionista desafiante u otro trastorno, trastorno de déficit atencional (ADD) o trastorno de déficit de atención e hiperactividad (ADHD), depresión, trastorno de ansiedad y trastornos de conducta alimentaria como anorexia o bulimia.
- **Otros:** Artritis, traumatismo encéfalo craneano, problemas del sueño, problemas dentales.

Fuente: OPS, 1995.